studeersnel

Bai giang lao - học - bài giảng

Y khoa (Đại học Tây Nguyên)



Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA Y DƯỢC

TÀI LIỆU HỌC TẬP
HỌC PHẦN LAO

Đăk Lăk tháng 5 năm 2019

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

MỤC LỤC

ĐẠI CƯƠNG LAO **Trang 03**
LAO SƠ NHIỄM **Trang 15**
LAO PHỔI **Trang 23**
LAO HẠCH **Trang 37**
LAO MÀNG PHỔI **Trang 41**
ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO **Trang 49**
XỬ TRÍ CẤP CỨU HO RA MÁU **Trang 64**

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH LAO

A. HÀNH CHÍNH

1. Tên môn học: Bệnh lao
2. Tên tài liệu học tập: Đại cương về bệnh lao
3. Bài giảng: Lý thuyết
4. Số tiết: 3 tiết
5. Đối tượng sinh viên: Y5 hệ 6 năm
6. Địa điểm giảng: Giảng đường

B. MỤC TIÊU

1. Hiểu được sơ lược bệnh sử lao.

2. Trình bày được 5 đặc điểm của bệnh lao

3. Trình bày được sinh bệnh học bệnh lao

4. Trình bày được tình hình bệnh lao hiên nay trên thế giới và ở Việt Nam

C. NỘI DUNG

1. MỞ ĐẦU:

Bệnh lao là một bệnh mãn tính có từ rất lâu đời. Tỉ lệ mắc lao hiện nay rất khác nhau tùy theo từng quốc gia khu vực, liên quan chặc chẽ với điều kiện phát triển kinh tế và chế độ xã hội, đặc biệt ở các nước đang phát triển tỉ lệ mắc lao vẫn còn khá phổ biến (như khu vực Tây thái bình dương và các nước châu Phi). Từ thập niên 80 của thế kỷ XX tại các nước Tây Âu và Bắc Mỹ người ta nghĩ rằng có thể khống chế và thanh toán được bệnh lao, tuy nhiên sau một thời gian dài do lơ là trong công tác phòng chống lao, kèm theo một số nguyên nhân chủ quan và khách quan (như đại dịch HIV, sự bùng nổ dân số, di cư...) làm cho bệnh lao có xu hướng gia tăng trở lại. Vì vậy, vào 4/1993 Tổ chức Y tế thế giới đã phải cảnh báo với thế giới rằng bệnh lao quay trở lại trên phạm vi toàn cầu (WHO 1993). Công tác phòng chống bệnh lao không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của cán bộ chuyên khoa lao và ngành y tế mà còn là trách nhiệm của mọi người mọi ngành trong xã hội. Vì vậy để góp phần làm giảm tỉ lệ nhiễm, mắc và chết do lao chúng ta cần phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho mọi người trong xã hội hiểu biết về bệnh lao và tham gia hưởng ứng tốt công tác phòng chống bệnh lao.

2. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ BỆNH LAO:

2.1. Trước thế kỷ XIX:

- Bệnh lao là một bệnh có từ rất lâu đời, có thể nói bệnh lao gắn liền với lịch sử phát triển của xã hội loài người, bằng chứng cho thấy người ta đã phát hiện ra di tích bệnh lao xương trong các xác ướp Ai cập cổ đại cách đây hàng ngàn năm.

- Thời kỳ Hypocrate (thế kỷ thứ V trước công nguyên (600 - 372 trước CN) người ta đã đề cập đến bệnh lao, nhưng chưa phân biệt được với các bệnh phổi khác, có lúc người ta cho là bệnh di truyền, có lúc cho rằng bệnh lây, và

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

người ta rất sợ bệnh này. Hypocrate gọi là bệnh "Phthisis" có nghĩa là "hư" (thường được viết tắc là ϕ hay φ), vào thời kỳ đó bệnh đã gây ra thảm họa lớn, cứ 7 người chết thì trong đó có 1 người chết do lao và người ta đã gọi đó là bệnh "dịch hạch trắng"

- Đông y cổ truyền đã xếp bệnh lao vào một trong bốn bệnh "tứ chứng nan y" đó là "phong, lao, cổ và lại" là một bệnh không chữa được.

- Từ thế kỷ XVI đến XVIII người ta cho đó là bệnh di truyền, không chữa được, quan niệm này đã tồn tại một thời gian rất dài và cho đến nay vẫn còn một số ít người thiếu hiểu biết vẫn còn có suy nghĩ sai lệch như vậy.

- Cũng có quan niệm cho rằng do một chất độc nào đó trong không khí gây ra bệnh lao, từ đó đã mở đường cho những nghiên cứu tìm kiếm nguyên nhân sau này.

2.2. Từ thế kỷ XIX đến nay: Nhờ những công trình nghiên cứu và tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà bệnh lao ngày càng được hiểu rõ hơn.

- Năm 1819 Laennec đã dùng phương pháp nghe để chẩn đoán bệnh lao phổi. Năm 1825 ông đã kết hợp giữa lâm sàng và giải phẫu bệnh để mô tả một số tổn thương lao. Ông chứng minh rằng bệnh lao không chỉ khu trú ở phổi mà còn gây tổn thương ở các cơ quan khác, cuối đời ông đã chết vì bệnh lao.

- Năm 1838 Sokolski đã mô tả chính xác các tổn thương chủ yếu của lao như: hang lao, củ lao (tubercule), ông đã nêu lên được sự liên quan mật thiết giữa lao phổi và viêm màng phổi (nhưng chưa biết đó là lao màng phổi) và đề cập đến tính chất xã hội của bệnh.

- Năm 1865, ông Villemin là người đầu tiên đã gây được bệnh lao thực nghiệm trên súc vật bằng cách lấy bệnh phẩm là đờm của người mắc bệnh lao phổi tiêm cho thỏ và đã gây được bệnh tích của bệnh lao ở thỏ tương tự như tổn thương lao ở người. Điều đó đã chứng minh rằng nguyên nhân gây bệnh lao có sẵn trong bệnh phẩm (là đờm của người mắc lao phổi), từ đó người ta cho rằng bệnh lao là một bệnh lây truyền từ cơ thể này sang cơ thể khác, nhưng nguyên nhân cụ thể là gì vẫn chưa được biết.

- Năm 1882 (ngày 24/3) Robert Koch (người Đức) đã tìm được nguyên nhân gây bệnh lao là một loại trực khuẩn (TK) bằng một phương pháp nhuộm đặc biệt (nhuộm Ziehl Neelsen) và gọi là trực khuẩn lao, viết tắc là BK (Bacillus de Koch). Ông cũng tìm ra được chất tuberculine và hiện tượng Koch (năm 1893) đã mở đầu cho việc nghiên cứu miễn dịch học bệnh lao sau này.

- Năm 1896 Roentgen đã tìm ra tia X, là một thành tựu khoa học quan trọng giúp cho việc chẩn đoán bệnh lao phổi dễ dàng và thuận lợi.

- Thế kỷ XX mở đầu cho những nghiên cứu về miễn dịch, dị ứng và phòng ngừa bệnh lao:

+ Năm 1907 Von Pirquet dùng phương pháp rạch da để phát hiện sự nhiễm lao.

+ Năm 1908 Mantoux đã dùng phương pháp tiêm tuberculine trong da để phát hiện sự nhiễm lao, đến nay vẫn còn là phương pháp được dùng phổ biến.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

+ Từ 1908, Calmette và Guérin bắt đầu nghiên cứu và công bố tìm ra vaccine BCG có tác dụng phòng ngừa bệnh lao vào năm 1921 (sau 13 năm nghiên cứu).

+ Vào thập niên 80, 90 của thế kỷ XX người ta đã áp dụng những phương tiện kỹ thuật hiện đại giúp cho việc chẩn đoán bệnh lao như: nội soi, ELISA, PCR (polimerase chain reaction).

2.3. Sơ lược quá trình phát triển của việc điều trị bệnh lao:

- Trước thời kỳ có kháng sinh kháng lao, việc điều trị bệnh lao chủ yếu là nghỉ ngơi, an dưỡng, ăn uống nâng cao thể trạng, Sana (an dưỡng đường) đầu tiên được thành lập ở Mỹ năm 1885 với mục đích như vậy. Người ta chữa lao hạch bằng cách đắp lá, châm cứu, hay vua sờ, (bệnh lao hạch lúc đó còn gọi là bệnh "vua sờ"). Forlanini lần đầu tiên dùng biện pháp như bơm hơi màng phổi, bơm hơi màng bụng để điều trị bệnh lao. Năm 1885 điều trị lao phổi bằng cách cắt cắt bỏ tổn thương hoặc cắt xẹp xương sườn.

- Năm 1944 Waksman tìm ra Streptomycine, là thuốc được dùng đầu tiên để chữa bệnh lao. Năm 1952 người ta tìm được hiệu quả điều trị lao của Rimifon (INH, Isoniazide) mặc dù thuốc đã được phát hiện từ năm 1912. Năm 1952 người ta cũng tìm ra thuốc Pirazinamide (PZA) và thuốc chỉ được đánh giá cao về hiệu quả điều trị lao vào năm 1978 sau khi đã hiểu rõ cơ chế tác dụng của thuốc. Năm 1961 thuốc Ethambutol (EMB) được phát hiện. Vào năm 1965 người ta đã bán tổng hợp được Rifampicine (RMP) là một loại thuốc kháng lao mạnh. Từ khi các loại thuốc kháng lao lần lượt ra đời, các phương pháp điều trị lạc hậu và điều trị ngoại khoa nhường chổ cho điều trị nội khoa; người ta hy vọng trong một tương lai không xa (đến cuối thế kỷ XX) sẽ có thể thanh toán được bệnh lao. Tuy nhiên chúng ta đã vấp phải một trở ngại lớn là vi trùng lao ngày càng kháng thuốc, ngoài ra còn nhiều lý do chủ quan cũng như khách quan khác khiến cho bệnh lao vẫn trường tồn, cho đến nay bệnh lao vẫn còn là một trong những bệnh có nhiều người mắc và chết khá phổ biến.

- Năm 1920 Hiệp hội chống lao quốc tế ra đời.

- Năm 1961 Hội nghị ở Toronto và Hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước XHCN họp năm 1962 đã thảo luận và công bố những hiểu biết về bệnh lao và biện pháp thanh toán bệnh lao.

- Các Hội nghị quốc tế ở Bruxelles (Bỉ 1978), Buenos Aires (Achentinia 1982), và ở Singapore (1986), thảo luận về chương trình chống lao trên thế giới và xác định bệnh lao có thể điều trị khỏi sau 6 tháng đến 1 năm, với hình thức điều trị ngoại trú là chủ yếu.

2.4. Lịch sử bệnh lao ở nước ta:

- Năm 250 trước công nguyên, thời An Dương Vương có thầy thuốc Thôi Vĩ đã dùng phương pháp châm cứu để chữa hạch cổ (mà lúc đó đa số là do lao).

- Tuệ Tỉnh (thế kỷ XV) cho rằng muốn điều trị bệnh lao phải dùng thuốc thang và bổ dưỡng.

- Thế kỷ XVIII Hải Thượng Lãn Ông (1720 - 1791) cho rằng bệnh ho lao là ho lâu ngày và là một bệnh truyền nhiễm.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Thời kỳ Pháp thuộc tình hình bệnh lao ở nước ta rất trầm trọng, do điều kiện kinh tế nghèo nàn lạc hậu, chiến tranh, nhân dân chịu nhiều áp bức bóc lột.

- Năm 1957 Viện chống lao trung ương thành lập ở phía Bắc, (đến tháng 9/1985 đổi thành Viện lao và bệnh phổi trung ương), ở phía Nam có bệnh viện lao Hồng Bàng nay là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

- Từ năm 1975 sau khi đất nước thống nhất, cả nước có một chương trình chống lao, phía Bắc có Viện lao và bệnh phổi trung ương, phía Nam có bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

- Năm 1976-1985 cả nước thực hiện chương trình chống lao 10 điểm.

- Năm 1985-1995 thực hiện chương trình chống lao cấp 2, mở rộng sự quản lý điều trị công thức 2 (có Rifampicine) xuống tận y tế xã phường, tuy nhiên chỉ mới thực hiện ở một số cơ sở điểm.

- Từ năm 1995 nhà nước quyết định thành lập chương trình chống lao quốc gia, đầu tư ngân sách kinh phí cho chương trình hoạt động, thực hiện chiến lượt "điều trị lao ngắn hạn có kiểm soát trực tiếp" - DOTS (Directly Observed Treatment Short course).

3. ĐẶC ĐIỂM BỆNH LAO:

3.1. Bệnh lao là một bệnh nhiễm khuẩn:

Vi khuẩn lao do Robert Koch phát hiện năm 1882, do đó còn gọi là Bacilie de Koch (BK). Vi khuẩn lao thuộc họ Mycobacteriaceae, dài từ 3 – 5 μm, rộng 0,3 – 0,5 μm, không có lông, hai đầu tròn, thân có hạt, chúng đứng riêng rẽ hoặc thành từng đám trên tiêu bản nhuộm Ziehl – Neelsen, không bị cồn và acid làm mất màu đỏ của fuscin.

3.1.1. Một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn lao:

a. Vi khuẩn lao có khả năng tồn tại lâu ở môi trường bên ngoài:

Ở điều kiện tự nhiên, vi khuẩn có thể tồn tại 3 – 4 tháng. Trong phòng thí nghiệm người ta có thể bảo quản vi khuẩn trong nhiều năm. Trong đàm của bệnh nhân lao ở phòng tối, ẩm sau 3 tháng vi khuẩn vẫn tồn tại và giữ được độc lực. Dưới ánh nắng mặt trời vi khuẩn bị chết sau 1,5 giờ. Ở 42 độ C vi khuẩn ngừng phát triển và chết sau 10 phút, ở 80 độ C và cồn 90° vi khuẩn tồn tại được 3 phút, trong acid phenic 5% vi khuẩn chỉ sống được một phút.

b. Vi khuẩn lao là loại vi khuẩn hiếu khí:

Khi phát triển vi khuẩn cần đầy đủ oxy, vì vậy giải thích vì sao lao phổi là thể bệnh gặp nhiều nhất và số lượng vi khuẩn nhiều nhất trong các hang lao có phế quản thông.

c. Vi khuẩn lao sinh sản chậm:

Trong điều kiện bình thường, trung bình 20-24h/lần, nhưng có khi hàng tháng, thậm chí nằm vùng ở tổn thương rất lâu, khi gặp điều kiện thuận lợi chúng có thể tái triển trở lại.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

d. Vi khuẩn lao có nhiều quần thể chuyển hóa khác nhau ở tổn thương:

Có những quần thể vi khuẩn phát triển mạnh, nằm ngoài tế bào (nhóm A) , có những quần thể vi khuẩn chậm, phát triển từng đợt (nhóm B), có những vi khuẩn nằm trong tế bào (nhóm C), Những quần thể này chịu tác dụng khác nhau tùy từng thuốc kháng lao.

e. Vi khuẩn lao có khả năng kháng thuốc:

*** Vi khuẩn lao kháng thuốc do đột biến trong gen:**

- Vi khuẩn kháng rifampicin đột biến ở gen rpo B mã hóa tổng hợp ARN-polymerase.
- Vi khuẩn kháng isoniazid đột biến ở gen Kat G, Inh A, ahp C.
- Vi khuẩn kháng streptomycin và các aminoglycosid: Đột biến ở gen rrS, rpsL hoặc cả hai gen này.
- Vi khuẩn kháng pyrazynamid: Đột biến ở gen pnc A

3.1.2. Phân loại vi khuẩn lao: Phân loại dựa vào khả năng gây bệnh cho người và động vật:

- Vi khuẩn lao người (M.tuberculosis Hominis)
- Vi khuẩn lao bò (M.bovis)
- Vi khuẩn lao chim (M.Avium)
- Vi khuẩn lao không điển hình (M.Atypique): M. kansasii, M. Aquae, M. Phlei, M. Marium, M. Microti.....).

Trong thực tế người ta dùng Niacin để phân biệt giữa vi khuẩn lao người và lao bò. Phản ứng Niacin dương tính hầu như chắc chắn là vi khuẩn lao người.

3.2. Bệnh lao là một bệnh lây:

Nguồn lây là những người mắc bệnh lao phổi có ho khạc ra trực khuẩn lao. Bệnh lây từ người bệnh sang người lành qua ba đường:

- *Đường hô hấp:*(là chủ yếu) do hít phải bụi, không khí, nước bọt, đàm của bệnh nhân có chứa vi khuẩn lao.
- *Đường tiêu hóa:* (hiếm gặp) do ăn, uống phải thức ăn bị nhiễm trực khuẩn lao.
- *Da và niêm mạc:* Rất hiếm gặp.
- **Nguồn lây chính nguy hiểm là những người mắc lao phổi có ho khạc ra vi khuẩn lao** (Có thể phát hiện bằng phương pháp nhuộm soi trực tiếp) là AFB (+). Các thể lao phổi nhưng không tìm thấy AFB (Acid fast Bacillus) trong đờm bằng phương pháp soi trực tiếp, bệnh lao phổi chỉ tìm thấy vi khuẩn khi nuôi cấy hoặc các thể lao ngoài phổi là những nguồn lây ít nguy hiểm hơn. Vì vậy chương trình chống lao thường ưu tiên phát hiện và điều trị một số bệnh nhân lao phổi có AFB dương tính.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Bệnh lao không di truyền. Rất hiếm gặp trường hợp TK lao truyền từ mẹ sang thai nhi bằng đường máu hay niêm mạc tử cung, nước ối (gọi là lao bẩm sinh). Năm 1983 Chu Văn Tường đã công bố một trường hợp lao bẩm sinh ở Việt Nam.

3.3. Bệnh lao có quá trình diễn biến qua hai giai đoạn:

- Giao đoạn lao nhiễm: Kể từ khi TK lao xâm nhập vào cơ thể lần đầu tiên (đường hô hấp), gây tổn thương ở phế nang (chanre); sau 2 tới 3 tháng cơ thể bị nhiễm hình thành miễn dịch và dị ứng lao, trở thành cơ thể nhiễm lao,giai đoạn này không có triệu chứng lâm sàng, chỉ có biểu hiện phản ứng Tuberculine(+). Điều may mắn là phần lớn (khoảng 90%) người bị lây dừng ở giai đoạn này.

- **Giai đoạn lao bệnh (còn gọi là bệnh lao thứ phát):** Chỉ xảy ra khi gặp điều kiện thuận lợi do sự mất cân bằng giữa sức đề kháng của cơ thể bị nhiễm và khả năng gây bệnh của TK lao (phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng, độc lực của TK, sức đề kháng của cơ thể...)

3.4. Bệnh lao có thể phòng ngừa và điều trị khỏi được:

- Phòng ngừa bằng cách tiêm phòng BCG vaccine cho trẻ em dưới một tuổi (tái chủng ở trẻ em 6-7 tuổi) có thể phòng được thể lao cấp tính nguy hiểm như lao kê, lao màng não. Ngoài ra việc nâng cao sức đề kháng bằng dinh dưỡng, vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống, cũng là một biện pháp phòng ngừa mắc bệnh lao.

- Bệnh lao nếu được phát hiện sớm và điều trị tích cực, kịp thời, đúng nguyên tắc có thể chữa khỏi hoàn toàn. Hiệu quả điều trị còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện kinh tế xã hội, sự hiểu biết, ý thức của người bệnh cũng như tổ chức mạng lưới y tế các cấp từ trung ương tới địa phương. Theo con số thống kê của Viện lao và bệnh phổi trung ương năm 1987 chỉ có khoảng 50% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng BCG. Việc phát hiện chỉ đạt được 2/3 tổng số bệnh nhân lao trong cả nước(1986). Tổng kết 5 năm (1981-1985) trên 243.359 bệnh nhân điều trị lao thấy có 69% điều trị đủ thời gian, 22,4% bỏ trị, chuyển 5,8%, chết 3,8%.

3.5. Bệnh lao là một bệnh xã hội:

Tính chất xã hội của bệnh đã dược nhiều người công nhận. Tỉ lệ mắc bệnh có liên quan chặt chẽ với đời sống kinh tế xã hội. Bệnh lao gia tăng ở những nước có trình độ dân trí thấp, điều kiện sống sinh hoạt thiếu thốn, mạng lưới y tế kém phát triển.

4. SINH BỆNH HỌC BỆNH LAO:

4.1. Nguyên nhân gây bệnh, nguồn lây và đường xâm nhập:

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

4.1.1. Nguyên nhân:

Gây bệnh lao ở người thường do TK lao người. Ngoài ra người ta còn phân lập được một số trường hợp là TK lao bò và TK lao không điển hình hiếm gặp.

4.1.2. Nguồn lây:

Chủ yếu là những người mắc bệnh lao phổi có ho khạc ra TK lao trong đờm (tức AFB dương tính) có thể phát hiện được bằng cách nhuộm soi đờm trực tiếp, đó là những nguồn lây chính nguy hiểm quan trọng.

4.1.3. Đường xâm nhập:

- Chủ yếu là đường hô hấp, do hít phải những mẫu bụi, không khí có chứa TK lao hoặc nước bọt, đờm của bệnh nhân ho khạc bắn ra. Vấn đề lây qua không khí đã được một số tác giả như W.F.Wells và CS (1934,1948) nghiên cứu cụ thể cho thấy đờm của bệnh nhân lao khạc ra không khí bốc hơi, khi chỉ còn là những hạt rất nhỏ (mắt thường không thấy được) bay lơ lững trong không khí và phân tán ra môi trường xung quanh. Trong hạt chứa một số TK lao theo không khí vào phế nang, tại đó TK lao sinh sản và phát triển gây tổn thương lao. L.Sultan và cộng sự (1960) đã cho chuột lang hít thở không khí được hút ra từ căn buồng có 6 bệnh nhân lao phổi có BK (+) đã gây được bệnh lao ở chuột lang.

- Xâm nhập qua đường tiêu hóa hoặc qua da, niêm mạc rất hiếm gặp.

4.2. Sự phát triển của tổn thương và lan tràn của TK lao:

Theo giả thuyết của Ranke (1916) cho rằng bệnh lao diễn biến qua 3 giai đoạn:

- *Giai đoạn 1:* TK lao xâm nhập vào cơ thể tạo phức hợp "phức hợ sơ nhiễm", mẫn cảm bắt đầu hình thành.

- *Giai đoạn 2:* Mẫn cảm tăng mạnh, TK lan tràn theo đường máu gây tổn thương ở các phủ tạng như phổi, hạch, khớp, màng não, màng phổi...

- *Giai đoạn 3:* Tổn thương khu trú gây bệnh ở một phủ tạng (thường là ở phổi)

Thuyết này có nhiều điểm hợp lý nhưng cũng có một số điểm ngoại lệ (chúng ta không tìm thấy bằng chứng của sự lan tràn của TK lao, hoặc đồng thời không thấy tổn thương ở các phủ tạng khác, hoặc không tìm thấy tổn thương lao sơ nhiễm mà chỉ có thể phát hiện được bằng chứng của sự nhiễm lao, thể hiện là test Tuberculline (IDR) dương tính.

Ngày nay nhiều tác giả đều công nhân giả thuyết bệnh lao có quá trình diễn biến qua hai giai đoạn: đó là giai đoạn lao nhiễm và giai đoạn lao bệnh.

4.2.1. Giai đoạn lao nhiễm:

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

TK lao lần đầu tiên khi vào cơ thể chưa mẫn cảm với lao đến phế nang gây tổn thương viêm lao đặc hiệu.

Trong 24 giờ đầu tại chỗ tổn thương tập trung nhiều bạch cầu đa nhân trung tính, các tế bào này có khả năng thôn tính nhưng không diệt được hết TK lao. Từ ngày thứ hai bạch cầu đa nhân dần dần được thay thế bằng các đại thực bào. Tùy theo số lượng và độc lực của TK lao mà đại thực bào có thể thôn tính hết toàn bộ hoặc chỉ một số TK lao. Một số TK lao sau khi bị thực bào vẫn có thể tồn tại lâu dài thậm chí phát triển ngay trong các đại thực bào (gọi là các TK nội bào). Các tế bào bán liên, lympho bào và tế bào khổng lồ (tế bào Langhans) hình thành. **Sau 15 đến 30 ngày** vùng trung tâm của tổn thương bị hoại tử đặc biệt thành một khối màu vàng nhạt, nhuyễn hóa (gọi là hoại tử bã đậu). Đây một hình thức diễn biến đặc biệt khác với các loại hoại tử khác, người ta cho rằng sở dĩ có hiện tượng này là do có ít lượng men thủy phân protein, hoặc do TK lao tạo ra chất ức chế men thủy phân protein. Kèm theo xuất hiện tổ chức xơ bao bọc bên ngoài xung quanh tổn thương và tạo thành nang lao điển hình. Tổn thương nang lao có thể diễn biến theo 2 hướng:

- *Diễn biến tốt:*

+ Hình ảnh tổ chức học dần dần trở lại bình thường (các tế bào bán liên, tế bào khổng lồ, lympho bào mất dần), tổ chức xơ mất dần hoặc tổn thương có thể xơ hóa hoặc vôi hóa, đây là hình thức xảy ra sớm.

+ Nếu tổn thương đã ở giai đoạn nhuyễn hóa bã đậu cũng có thể tiến tới ổn định (không hoạt động).Mặc dù có lớp xơ bao bọc nhưng vẫn còn chất bã đậu bên trong, TK lao vẫn có thể chưa chết (hình thức TK lao dai dẳng) và có thể hoạt động trở lại khi gặp điều kiện thuận lợi, trên lâm sàng thể này thường gặp với hình ảnh X-quang dạng nốt, hoặc nốt vôi hóa mà không có triệu chứng lâm sàng.

- *Diễn biến xấu (có thể chuyển sang giai đoạn lao bệnh):*

+ Chất bã đậu nhuyễn hóa dạng nước, ăn mòn lan rộng, nếu thông với phế quản chất bã đậu sẽ thoát ra hình thành hang lao.

+ Các TK lao có thể theo đường bạch huyết đến hạch trung thất gây viêm và hình thành "phức hợp nguyên thủy" (gồm hạch trung thất viêm + sang thương phế nang (chancre)+ viêm mạch bạch huyết).

+ Từ tổn thương lao sơ nhiễm TK lao theo đường máu hoặc mạch bạch huyết vào hệ tuần hoàn chung của cơ thể. Trong quá trình đó, TK lao có thể xâm nhập khu trú và gây tổn thương ở một số cơ quan (phổi, thận, xương khớp hoặc các màng...). Lúc này trong cơ thể đã hình thành phản ứng dị ứng và miễn dịch. Ở phổi thường gặp tổn thương ở phân thùy đỉnh sau (phân thùy 2) và phân

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

thùy Fowler (phân thùy 6). Cơ chế của hiện tượng này là do khuynh độ (Gradient) lớn của áp suất huyết động ở vùng này so với thất phải nên có sự chậm lại của dòng máu, tạo điều kiện thuận lợi cho TK lao dừng lại, khu trú và gây tổn thương ở phổi, ngoài ra còn do áp lực riêng phần oxy ở đỉnh phổi cao hơn ở vùng khác.

+ Sự lan tràn của TK lao phụ thuộc vào số lượng, khả năng gây bệnh (độc lực) của TK lao và sức đề kháng của cơ thể bị lây.

+ Các tổn thương có thể khỏi hoàn toàn, thành sẹo xơ hóa hoặc vôi hóa vĩnh viễn không hoạt động; hoặc ở dạng ổn định tạm thời, khi gặp điều kiện thuận lợi, TK lao lại phát triển và gây bệnh lao tại các cơ quan về sau (gọi là bệnh lao do TK lao nội sinh tái hoạt). Trong quá trình lan tràn theo đường máu (hay đường bạch huyết) TK lao có thể gây tổn thương lao cấp tính ở nhiều bộ phận cơ thể.

Tóm lại: Giai đoạn lao nhiễm là sau khi BK xâm nhập vào cơ thể gây lao sơ nhiễm, từ đó lan tràn theo đường máu (hay bạch huyết) gây tổn thương ở một số cơ quan. Về mặt sinh học giai đoạn này hình thành dị ứng và miễn dịch chống lao. Đa số các trường hợp không có triệu chứng lâm sàng. Chỉ biểu hiện triệu chứng lâm sàng ở một số bệnh cảnh cấp tính. Có thể nói chủ yếu ở giai đoạn này là giai đoạn lao nhiễm.

4.2.2. Giai đoạn lao bệnh (bệnh lao thứ phát):

Nguyên nhân gây bệnh lao thứ phát là do nguồn gốc BK nội sinh tái hoạt hay ngoại sinh (tái nhiễm) đã được nhiều tác giả tranh luận, nhất là khi có thuốc đặc trị lao.

- *Nguyên nhân do TK lao ngoại sinh (tái nhiễm):* Có tác giả cho rằng nguyên nhân gây bệnh lao thứ phát là do BK mới nhiễm vào cơ thể. Đại diện cho trường phái này là G.canetti, ông đã báo cáo ở hội nghị chống lao quốc tế 21 (Maxcơva, 1971) cho rằng TK lao không thể tồn tại vĩnh viễn trong các tổn thương trong cơ thể. Ông tìm thấy trong tổn thương bã đậu có vỏ xơ bao bọc có 50% trường hợp không tìm thấy TK lao.

- *Nguyên nhân do TK lao nội sinh tái hoạt:* Có tác giả cho rằng bệnh lao thứ phát gây ra do nguồn gốc BK đã có sẵn trong các tổn thương cũ từ các ổ lao sơ nhiễm. Đại diện cho trường phái này là W.W.Stead, tại hội nghị chống lao quốc tế 23 (Tokyo,1973) cho rằng đa số các trường hợp lao phổi người lớn là do TK còn tồn tại trong các tổn thương lao sơ nhiễm, khi gặp điều kiện thuận lợi đã phát triển và gây bệnh. Bằng cách dùng typ thực khuẩn thể (phage) của TK lao, ông đã chứng minh cho thấy rất ít khi có 2 loại thực khuẩn thể trên cùng một người bệnh.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Theo Ferguson và CS (1941 – 1955) ở Canada và HorWits (Đan Mạch, 1969) cho rằng TK lao nội sinh hay ngoại sinh đều có thể gây bệnh lao thứ phát, nhưng nguyên nhân nào chiếm ưu thế thì phụ thuộc vào nguồn lây. Nếu nguồn lây còn phổ biến thì vai trò của TK lao ngoại sinh là đáng kể và ngược lại. Nước ta và các nước đang phát triển ở Châu Á, Châu Phi và Mỹ La Tinh tình hình bệnh lao còn rất đang phổ biến, nguy cơ nhiễm lao hàng năm cao từ 2-5% thì nguồn TK lao ngoại sinh tái nhiễm không phải là không có ý nghĩa trong bệnh sinh lao phổi ở người lớn.

- *Quá trình chuyển sang lao bệnh:*

Một điều đáng mừng là quá trình diễn biến của bệnh lao phần lớn chỉ giữ ở tình trạng lao nhiễm mà không chuyển sang lao bệnh. Người ta thấy chung cho mọi lứa tuổi chỉ khoảng 10% tình trạng nhiễm lao chuyển sang lao bệnh, trong đó có đến 80% chuyển sang lao bệnh trong hai năm đầu tiên. Trong số lao bệnh có khoảng 50% sẽ là nguồn lây mới. Như vậy cứ một nguồn lây khi lây cho 20 người sẽ có 2 người mắc lao và trong đó có 1 người sẽ là nguồn lây mới, đây là lí do khiến cho bệnh lao trường tồn.

Cơ chế chuyển từ lao nhiễm sang lao bệnh còn chưa được hiểu biết một cách đầy đủ, người ta cho rằng nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: số lượng và độc lực của TK, tuổi, giới, cơ địa, chủng tộc, yếu tố di truyền, đặc biệt là sức đề kháng của cơ thể.

- *Theo L.B.Edward và cộng sự (1971) nghiên cứu trên 823.199 tân binh Mỹ cho thấy khả năng bị bệnh lao tăng theo chiều cao và giảm theo cân nặng (người gầy mắc lao cao gấp 3 lần người béo). A.T.Verdal (1982) cho thấy chỉ số mắc lao giảm khi chỉ số khối cơ thể tăng. L.A.Aris và CS thấy có sự chênh lệch có ý nghĩa về tần số phenotyp BW15 (hệ thống HLA). Tỷ lệ mắc lao cao gấp 8 lần nhiều hơn ở ngừoi có BW15 (+) so với ngừoi không có BW15. Tác giả cũng thấy ở ngừoi bệnh có BW15 (+) tổn thương lao nặng hơn, tái phát nhiều hơn và mắc lao ngoài phổi nhiều hơn.*

- Cơ địa đái đường, loét dạ dày tá tràng, cắt dạ dày, suy dinh dưỡng, bụi phổi, các bệnh ác tính , bệnh nhiễm trùng, stress... đặc biệt là nhiễm HIV/AIDS là những điều kiện thuận lợi làm tăng nguy cơ mắc bệnh lao.

5. TÌNH HÌNH BỆNH LAO HIỆN NAY:

5.1. Tình hình bệnh lao trên thế giới:

- Bệnh lao vẫn còn là bệnh có số người mắc và chết chiếm tỉ lệ cao; là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai trong các bệnh nhiễm trùng. Tình hình dịch tễ lao kháng thuốc đang có diễn biến phức tạp và đã xuất hiện ở hầu hết các quốc gia.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (năm 2013), trên toàn cầu khoản 7,2 tỉ dân, có 1/3 dân số nhiễm lao, khoản 12 triệu người mắc lao mới hàng năm, mỗi năm có đến 4 triệu người chết vì bệnh lao. Tỷ lệ mắc lao đa kháng thuốc chiếm 3,5% trong số bệnh nhân mới, và chiếm 20,5% trong số bệnh nhân điều trị lại.

Có 5 nguyên nhân làm cho bệnh lao gia tăng:

+ Do đại dịch HIV/AIDS, một người bình thường nếu bị nhiễm lao sẽ có nguy cơ mắc bệnh lao từ 5 đến 10% trong cả cuộc đời. Nhưng nếu một người nhiễm lao đồng thời với nhiễm HIV thì nguy cơ mắc lao sẽ là 30-50%.

+ Do di dân tự do từ các nước có tỉ lệ bệnh lao cao đến các nước phát triển.

+ Do sự bùng nổ về dân số làm cho số lượng tuyệt đối bệnh nhân lao không ngừng gia tăng.

+ Do sự lơ là thiếu quan tâm của xã hội và chính phủ của nhiều nước, đặc biệt là các nước phát triển đã chủ quan, quên lãng một thời gian dài, cùng với việc tổ chức chương trình chống lao kém hiệu quả ở một số nước.

+ Một hậu quả đáng lo ngại là sự xuất hiện nhiều chủng lao kháng thuốc. Theo BS. Kochi (WHO) hiện nay trên thế giới có khoảng 50-100 triệu người đã nhiễm loại TK lao kháng thuốc.

- Ở các nước phát triển (châu Âu và Bắc Mỹ): tình hình bệnh lao đã giảm nhiều. Đầu những năm 1980 tỉ lệ nhiễm lao ở lứa tuổi 14 rất thấp (khoảng 1% - 5%), nguy cơ nhiễm lao hàng năm (R: Risk) thấp R= 0,1 - 0,3%, mức giảm nguy cơ nhiễm lao hàng năm từ 10 - 12%.

- Tại các nước đang phát triển:

+ Ở châu Phi (qua thăm dò 18 nước) cho thấy R ≥ 3% mức giảm nguy cơ nhiễm lao hàng năm chỉ đạt 1,5 - 2%.

+ Châu Mỹ la tinh R = 0,5 - 1,5% mức giảm R hàng năm là 2 - 2,5%

+ Châu Á R = 1 - 2% mức giảm R hàng năm là 1,5 - 2,5%

Theo tính toán của Styblo (WHO) nếu dịch lao phát triển tự nhiên cho thấy tương ứng với R=1% sẽ có 50 trường hợp BK(+) mới/100.000 dân. Từ đó người ta tính được sự tương quan giữa các chỉ số dịch tễ là: 1P = 2I = 4M (P: prevalence (tổng số mắc lao), I: Incidence (Chỉ số lao mới hàng năm), M: Mortality (chỉ số tử vong).

5.2. Tình hình bệnh lao ở Việt Nam:

Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, xếp thứ 12 trong số 22 nước có số người bệnh lao nhiều nhất thế giới, đứng thứ 14 trong số 27 nước có gánh nặng bệnh lao đa kháng thuốc.

Theo báo cáo của Viện Lao và bệnh phổi Trung ương (năm 2014) toàn quốc đã phát hiện 102.070 bệnh nhân lao các thể, với tỷ lệ phát hiện là 111,35/100.000 dân; trong đó có 49.934 bệnh nhân lao phổi AFB (+). So sánh với năm 2013, số bệnh nhân lao phổi mới phát hiện trong năm 2014 tiếp tục giảm 673 bệnh nhân; tỷ lệ điều trị khỏi bệnh nhân lao phổi AFB (+) đạt 89,93%, trong đó có 13% bệnh nhân mắc lao có đồng nhiễm HIV.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

TK lao nhạy cảm với thuốc là 67,5%, tỉ lệ kháng thuốc chung là 32,5%; điều đáng mừng là tỉ lệ đa kháng thuốc (kháng R và H) chưa cao (2,3%). Để tránh tình trạng đa kháng thuốc cần tăng cường chiến lược hóa trị liệu ngắn ngày có kiểm soát trực tiếp tích cực và hiệu quả.

Hội nghị quốc tế chống lao năm 1962 qui định tiêu chuẩn thanh toán bệnh lao:

* Nếu tỉ lệ nguồn lây AFB(+) mới hàng năm > 50/100.000 dân, bệnh lao vẫn còn khá phổ biến.

* Nếu AFB(+) < 50/100.000 dân, bệnh lao đã được khống chế.

* Nếu AFB(+) < 10/100.000 dân có nghĩa bệnh lao đã được thanh toán.

Tuy nhiên hiện nay Tổ chức Y tế thế giới đã nâng ***tiêu chuẩn thanh toán bệnh lao khi chỉ còn 01 trường hợp AFB(+) mới/1.000.000 dân*** Tại Hội nghị chống lao quốc tế năm 1990 ở Boston, các nước dự kiến: Hà Lan sẽ đạt tiêu chuẩn trên vào năm 2025, Nhật Bản vào năm 2050.

Tóm lại: Sau một loạt các thuốc kháng lao được phát hiện, người ta đã hy vọng có thể thanh toán được bệnh lao vào cuối thế kỷ XX, tuy nhiên cho đến nay (thập niên đầu của thế kỷ XXI) bệnh lao vẫn còn là một bệnh mà xã hội cần phải quan tâm, đặc biệt ở các nước đang phát triển, bệnh lao đang còn khá phổ biến. Do đó nhiệm vụ của chương trình chống lao, của ngành y tế nói riêng và của toàn xã hội nói chung cần phải phấn đấu tích cực hơn nữa mới mong thanh toán được bệnh lao vào cuối thế kỷ này.

Tóm lại: Sau một loạt các thuốc kháng lao được phát hiện, ngươi ta đã hy vọng có thể thanh toán bệnh lao vào cuối thế kỷ XX, tuy nhiên cho đến nay bệnh lao vẫn còn là một bệnh mà xã hội cần phải quan tâm, đặc biệt ở các nước đang phát triển bệnh lao đang còn khá phổ biến. Do đó nhiệm vụ của chương trình này.

Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu học tập phát tay, Bộ Môn Lao, Đại Học Tây Nguyên 2005.

2. Bệnh học lao, GS.TS.Trần Văn Sáng, NXB Y học, Hà Nội 2007

3. Bài giảng lao và bệnh phổi, NXB Y học, Hà Nội năm 1999

4. Hướng dẫn thực hiện chương trình chống lao quốc gia, NXB Y học, Hà Nội 1999.

5. Tài liệu hướng dẫn bệnh lao (Tài liệu dịch), NXB Y học, Hà Nội 2001

6. Bệnh học lao, NXB Y học, Hà Nội 2002.

7. Bệnh học lao, Bộ Môn Bệnh học lao và bệnh phổi, Đại Học Y Dược TP.HCM 2015.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

LAO SƠ NHIỄM

A. HÀNH CHÍNH

1. Tên môn học: Bệnh lao
2. Tên tài liệu học tập: Lao sơ nhiễm
3. Bài giảng: Lý thuyết
4. Số tiết: 2 tiết
5. Đối tượng sinh viên: Y5 hệ 6 năm
6. Địa điểm giảng: Giảng đường

B. MỤC TIÊU

1. Trình bày được các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của lao sơ nhiễm.

2. Nêu được các yếu tố chẩn đoán lao sơ nhiễm.

3. Trình bày được các điều trị và phòng bệnh lao sơ nhiễm.

C. NỘI DUNG:

1. Đại cương:

Trong cơ thể con người lần đầu tiên tiếp xúc với vi khuẩn lao, thường 90% trường hợp chỉ bị nhiễm lao còn 10% trường hợp là ở giai đoạn lao bệnh, nghĩa là bị bệnh lao. Tỷ lệ 10% này người ta gọi là lao sơ nhiễm.

Tổn thương của lao sơ nhiễm có thể ở phổi hoặc ngoài phổi tùy theo đường xâm nhập của trực khuẩn lao, nhưng biểu hiện ở phổi là hay gặp nhất.

Triệu chứng lâm sàng thường không đặc hiệu, do đó cần khai thác kỹ tiền sử, bệnh sử cũng như khám lâm sàng và cận lâm sàng một cách đầy đủ mới có chẩn đoán đúng. Việc chẩn đoán và điều trị muộn sẽ để lại những biến chứng nặng nề cho bệnh nhân như lao kê, lao màng não, xẹp phổi...

2. Dịch tễ học:

2.1. Tình hình lao sơ nhiễm ở trẻ em khác nhau ở các nước trên thế giới. Ở Việt Nam tuy chưa được thống kê đầy đủ, nhưng qua số liệu tham khảo cho thấy tỷ lệ mắc lao sơ nhiễm khoảng 10 – 13/100.000 trẻ em.

2.2. Tuổi mắc bệnh:

Trẻ 1 – 5 tuổi chiếm tỷ lệ 91%. Trẻ từ 0 – 1 tuổi chiếm tỷ lệ 25% (Theo Phạm Khắc Quảng), hiện nay có xu hướng gia tăng ở người lớn do sự lan tràn của bệnh AIDS.

2.3. Điều kiện thuận lợi:

- Chưa chủng ngừa BCG.
- Tiền sử gia đình có người bị lao phổi AFB(+), tiếp xúc nguồn lây mạnh.
- Suy dinh dưỡng.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Mắc bệnh nhiễm trùng, virus
- Dùng corticoid kéo dài.
- Điều kiện vệ sinh môi trường kém.

3. Nguyên nhân - sinh bệnh học:

3.1. Nguyên nhân:

Chủ yếu do trực khuẩn lao người (Mycobacterium tuberculosis hominis), ngoài ra còn có thể từ vi khuẩn lao bò M.Bovis, hoặc lao không điển hình.

3.2. Nguồn lây:

Do tiếp xúc với bệnh nhân lao phổi ho khạc đàm có AFB(+), nhất là người trong gia đình có cha, mẹ, ông, bà hoặc trong trường học, nhà trẻ, nhà tù... Trẻ em dễ bị lây nhưng ít khi là nguồn lây vì trẻ em chỉ có tỷ lệ nhỏ (5%) có AFB(+) trong đàm soi trực tiếp. Mặt khác trẻ em thường nuốt đàm chứ không khạc ra ngoài.

3.3. Đường lây:

Chủ yếu qua đường hô hấp, ngoài ra còn có thể qua đường tiêu hóa, da, niêm mạc.

3.4. Sinh bệnh học:

Trực khuẩn lao đi vào phổi của một cơ thể chưa bị nhiễm lao trước đó, những trực khuẩn này lắng đọng trong đường dẫn khí với phế nang, thường ở cạnh màng phổi. Tại đây chúng nhân đôi và kích thích phản ứng viêm cấp không đặc hiệu. Trong 24 giờ đầu tại tổn thương có nhiều bạch cầu đa nhân hầu như không thể diệt trực khuẩn lao.

Sang ngày thứ hai các bạch cầu đa nhân được thay thế bởi các đại thực bào. Tùy theo số lượng và khả năng gây bệnh, đại thực bào có thể nuốt và tiêu diệt một số trực khuẩn lao nhưng một số khác sau khi bị đại thực bào nuốt lại có thể tồn tại và sinh sản trong đại thực bào.

Trong thời gian từ 2 – 8 tuần sau khi tiếp xúc với trực khuẩn lao, cùng lúc trực khuẩn lao đang tiếp tục nhân đôi trong môi trường nội bào thì hiện tượng quá mẫn trung gian tế bào xảy ra. Do phản ứng miễn dịch, các lympho bào trưởng thành tập hợp đến vùng bị nhiễm, chúng phóng thích các yếu tố hóa ứng động interleukine và lymphokines. Để đáp ứng, các monocytes đi vào máu và trải qua sự chuyển dạng thành các đại thực bào và tiếp tục thành những mô bào được chuyên biệt hóa mà tổ chức thành những u hạt (granulomas). Trực khuẩn lao có thể tồn tại ngay trong đại thực bào, mặc dù có sự gia tăng sản sinh lyzozymes trong những tế bào này, nhưng sự nhân đôi và lan rộng bị hạn chế sau đó sự lành bệnh xảy ra. Có hiện tượng vôi hóa những u hạt của tổn thương phổi ở phần ngoại vị gọi là "Ghon focus".

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

Trong suốt giai đoạn sớm của quá trình nhiễm lao, thường sự lan rộng của vi khuẩn lao đến những vùng hạch bằng đường bạch huyết và làm tổn thương hạch vùng. Sự phối hợp của quá trình calci hóa một sang thương nhẹ mô phổi ở ngoại vi và sự phì đại hạch lympho vùng rốn phổi thành phức hợp sơ nhiễm (Phức hợp Ghon). Các tổn thương có thể diễn biến theo chiều hướng tốt. Hình ảnh tổ chức học dần dần trở lại bình thường. Các tế bào bán liên, tế bào lympho, tế bào khổng lồ mất dần, tiến triển có thể xơ hóa hoặc vôi hóa hoặc lành bệnh hẳn. Nếu tổn thương chuyển sang giai đoạn nhuyễn hóa bã đậu thì chỉ có thể diễn biến đến ổn định không hoạt động, vì mặc dù được bao bọc bởi một vỏ xơ nhưng bên trong vẫn còn chất bã đậu với khả năng còn TK lao chưa chết (TK lao nằm chờ thời cơ).

Ngược lại, tổn thương có thể diễn biến theo hướng xấu, chất bã đậu hóa lỏng chuyển sang dạng dịch và nếu thông được với phế quản có thể thoát ra ngoài đường phế quản dẫn và tổn thương sẽ thành dạng hang lao. Hầu hết các tổn thương lao ban đầu đều tự khỏi, dù rằng chúng có thể tồn tại khả năng tiềm tang hoạt động trở lại sau này.

TK lao lan tràn từ tổn thương nguyên phát theo đường bạch huyết, đường máu xâm nhập vào hệ thống tuần hoàn chung của cơ thể. Trong quá trình lan tràn đó, TK lao gây tổn thương ở một số cơ quan như phổi, phần vỏ nhu mô thận, các đầu xương, các màng (bao gồm màng não, màng phổi, màng tim...). TK lao lan tràn theo đường máu gây ra bệnh cảnh cấp tính như lao kê, lao hệ thống thần kinh trung ương, đặc biệt ở trẻ nhỏ, những người bị bệnh AIDS.

4. Giải phẫu bệnh:

Tổn thương trong lao sơ nhiễm là phức hợp nguyên thủy (phức hợp sơ nhiễm) gồm săng sơ nhiễm, viêm hạch trung thất nối với nhau bằng đường bạch huyết viêm.

- Săng sơ nhiễm: Ở phổi là là tổn thương phế nang đặc hiệu với những nang lao điển hình. Săng sơ nhiễm thường nhỏ, đường kính nhỏ hơn 1cm và có thể vôi hóa khó phát hiện khi quan sát đại thể.

- Viêm hạch trung thất: Thường xuất hiện muộn hơn sang sơ nhiễm và kích thước khá lớn kèm viêm nhiều nhóm hạch, các hạch dần hoại tử bã đậu và có thể vôi hóa.

- Viêm đường bạch huyết: Thường hoại tử bã đậu, có thể có hạt kê xung quanh đường bạch huyết.

5. Lâm sàng:

Các triệu chứng lâm sàng đa dạng và không đặc hiệu và ít giúp chẩn đoán, nhưng có tầm quan trọng lớn trong việc phát hiện bệnh.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

5.1. Giai đoạn khởi phát:

- Bệnh khởi phát từ từ với các triệu chứng như sốt nhẹ kéo dài, ho khan từng cơn biểu hiện rõ về chiều và đêm, gầy sút cân, kém ăn, quấy khóc và rối loạn tiêu hóa kéo dài, thể này chiếm khoảng 80%

- Bệnh có thể cấp tính với sốt cao kéo dài liên tục nhiều ngày, kèm co giật nôn mữa hoặc kèm ban nút đỏ ở mặt trước cẳng chân (hiếm gặp, xuất hiện 3 – 4 ngày rồi mất), thể này chiếm 20%

5.2. Giai đoạn toàn phát:

- Triệu chứng toàn thân: Các triệu chứng của giai đoạn khởi phát tăng dần lên như sốt kéo dài, quấy khóc, gầy sút cân, kém ăn, ra mồ hôi trộm, mệt mỏi... hoặc sốt cao kéo dài, mạch nhanh, co giật kèm xanh xao, niêm mạc nhợt, tiểu ít...

- Triệu chứng cơ năng: ho khan hoặc ho có đàm, khó thở, thở khò khè, thở rít.

- Triệu chứng thực thể: thường nghèo nàn

+ Có thể nghe rale rít, ngáy ở khoang liên sườn 3 – 4 ở trước ngực phải (Do hạch trung thất chèn ép một phân thùy).

+ Có thể có hội chứng 3 giảm ở 1/3 trên phổi phải.

+ Có thể viêm kết mạc phỏng nước hoặc ban nút đỏ trước cẳng chân.

6. Cận lâm sàng:

6.1. Phản ứng tuberculin:

Đây là xét nghiệm quan trọng nhất trong lao sơ nhiễm trẻ em. Đối với trẻ đã chủng BCG thì dương tính mạnh, còn trẻ chưa chủng BCG thì sự chuyển dương của phản ứng rất có giá trị. Tuy nhiên đối với trẻ suy dinh dưỡng, kèm lao kê, lao màng não, nhiễm virus, suy giảm miễn dịch, có dùng thuốc corticoid phản ứng có thể âm tính.

6.2. X-quang phổi:

Có thể biểu hiện nhiều dạng khác nhau nhưng điển hình và đặc trưng nhất của lao sơ nhiễm là phức hợp nguyên thủy gồm săng sơ nhiễm, viêm hạch trung thất nối với nhau bằng đường viêm bạch huyết.

Săng sơ nhiễm khó phát hiện trên X-quang phổi hay gặp ở thùy trên có thể ảnh hưởng lên phân thùy trước cũng như phân thùy sau. Trên X-quang là một bong mờ đều, tròn hay bầu dục, bờ nhạt, đường kính khoảng 1 cm, thấy rõ khi săng sơ nhiễm bị vôi hóa. Đường viêm bạch huyết là đường mờ đường kính 1 – 2mm nối săng sơ nhiễm – hạch trung thất. Hạch trung thất trên phim X-quang có hình tròn, bầu dục làm trung thất bị rộng ra, thường gặp phì đại hạch

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

một bên. Hay gặp phì đại hai nhóm hạch: Hạch cạnh khí quản phải (I), hạch rốn phổi phải (III) 50%, tổng hợp là hình ảnh giống như quả tạ.

- Có thể trên X-quang lao sơ nhiễm chỉ có phì đại hạch trung thất đơn thuần. Đay là dấu hiệu đặc trưng của lao sơ nhiễm trẻ em, nếu người lớn có thể phải phân biệt ung thư phế quản.

- Xẹp phân thùy phổi: Do hạch trung thất chèn ép, hình ảnh X-quang mờ đậm đều hình tam giác đỉnh quay vào trong.

- Tràn dịch màng phổi từ nhẹ đến trung bình có thể xảy ra viêm rãnh liên thùy do săng sơ nhiễm nằm cạnh rãnh liên thùy.

6.3. Các xét nghiệm khác:

- Tìm AFB trong đàm, dịch rửa dạ dày... Tỷ lệ dương tính thấp (14%) bằng phương pháp nhuộm soi trực tiếp.

- Xét nghiệm máu: Công thức hồng cầu, bạch cầu bình thường, ngoại trừ lymphocyte tăng, tốc độ lắng máu tăng.

- Soi phế quản: Chỉ định khi có rối loạn thông khí (xẹp phổi), để tìm tổn thương đặc hiệu của lao hoặc lỗ dò của hạch phế quản hoặc lấy dịch phế quản làm xét nghiệm tìm AFB.

- Tìm sự lan tỏa của trực khuẩn lao: Tùy theo diễn biến lâm sàng của cơ quan bị tổn thương mà cần làm thêm:

+ Soi đáy mắt

+ Chọc dò dịch não tủy

+ Chụp X-quang xương khớp

+ Khám sinh dục tiết niệu

7. Các thể lâm sàng:

7.1. Thể bệnh theo tuổi:

- Lao sơ nhiễm ở trẻ nhỏ: Đây là một thể nặng vì các triệu chứng lâm sàng dễ bỏ qua. Trẻ thường sốt nhẹ, bỏ bú, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, khó thở do hạch trung thất chèn ép. Bệnh thường kèm theo lao kê, lao màng não (Nếu trẻ không được chủng ngừa BCG)

- Lao sơ nhiễm ở người trưởng thành: Ít gặp nhưng nếu có thì triệu chứng lâm sàng rõ, X-quang dễ phát hiện tổn thương, bệnh tiến triển nhanh tới lao phổi cấp hoặc mãn. Ngày nay, từ khi có dịch HIV, bệnh cơ hội khi chuyển AIDS là lao. Biểu hiện lao sơ nhiễm kèm biến chứng lao kê, lao màng não.

7.2. Thể theo triệu chứng lâm sàng:

- Lao sơ nhiễm thể tiềm tàng: Không sốt, mệt mỏi, kém ăn, rối loạn tiêu hóa, đôi khi có dấu hiệu cảm cúm hoặc viêm phổi. **Dấu hiệu duy nhất là phản ứng tuberculin dương tính.**

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Thể thương hàn: Xảy ra đột ngột với sốt cao tăng dần, mệt mỏi, lách to, ho, mạch nhiệt phân ly, lưỡi sạch.

- Thể ban nút đỏ: Một tuần sau xuất hiện những nốt đường kính 1 – 3 cm màu hồng, ấn đau ở mặt trước cẳng chân và khớp gối. Bệnh diễn tiến từng đợt cách nhau 3 – 4 ngày. Các nốt chuyển sang tím rồi vàng và biến mất. Thường kết hợp phức hợp nguyên thủy và dễ có biến chứng.

- Thể viêm kết mạc phỏng nước: Bệnh nhân sợ ánh sáng, có bọng nước nhỏ bằng đầu đinh ghim ở kết mạc và giác mạc xuất hiện sớm và phối hợp với các triệu chứng ở các cơ quan khác nhau.

7.3. Thể lây theo tiêu hóa:

- Do mẹ bị lao mớm cơm cho con ăn gây săng sơ nhiễm ở miệng kèm theo hạch dưới hàm.

- Lao sơ nhiễm ở ruột: Do uống sữa bò bị lao, có rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc tiêu chảy phân sống, nôn mửa, có khối u ở hố chậu phải (u hạch mạc treo).

8. Tiến triển và biến chứng:

8.1. Tiến triển tốt:

Nếu phát hiện sớm bệnh, điều trị kịp thời thì các triệu chứng lâm sàng thường sẽ mất sau hai tuần. X-quang phổi mất sau 2 – 3 tháng ngoại trừ những nốt vôi hóa còn vĩnh viễn. Hạch trung thất sẽ mất sau 6 tháng với 1 năm, phản ứng tuberculin có thể tồn tại 6 tháng đến 1 năm.

8.2. Biến chứng:

Thường do không điều trị lao hoặc điều trị không đúng, không kịp thời hoặc do bệnh phối hợp như tiểu đường, nhiễm HIV, các biến chứng hay gặp là:

- Xẹp phổi: Do hạch trung thất chèn ép hoặc do đàm hay do chất bã đậu, chất tiết phế quản làm tắc long phế quản.

- Dò hạch vào phế quản gây phế quản phế viêm lao

- Khí phế thủng phổi

- Lao kê, lao màng não do trực khuẩn lao theo đường máu tới các cơ quan khác.

- Lao màng phổi, lao xương khớp do trực khuẩn lao theo đường bạch huyết đến.

- Dò sẹo phế quản, giãn phế quản, vôi hóa thành phế quản (do hạch trung thất vỡ) gây ho ra máu.

Tiên lượng bệnh phụ thuộc vào:

+ Đặc điểm trực khuẩn lao gây bệnh: Số lượng, độc tính...

+ Tuổi: Dưới 1 tuổi tiên lượng nặng hơn.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

+ Sức khỏe chung: bệnh làm suy giảm miễn dịch bệnh nặng hơn: AIDS...

9. Chẩn đoán:

9.1. Chẩn đoán xác định: Dựa vào:

- Tiền sử tiếp xúc với nguồn lây đóng vai trò quan trọng nhất lao sơ nhiễm ở trẻ nhỏ. Nguồn lây từ người trong gia đình như cha mẹ, ông bà hay nguồn lây từ phía nhà trường như thầy cô giáo, những người có lao phổi AFB(+).

- Không chủng BCG hoặc có chủng nhưng tiếp xúc nguồn lây trực tiếp và liên tục.

- Dựa vào biểu hiện lâm sàng: Sốt nhẹ hoặc sốt cao kéo dài, ho khan từng cơn kèm khó thở, thở nhẹ, thở khò khè, sút cân, ra mồ hôi, quấy khóc, bỏ bú... Thực thể nghe được rale rít ngay trước ngực phải khoang liên sườn 3 – 4 hoặc có ban nút đỏ ở mặt trước ở cẳng chân.

- Dựa vào cận lâm sàng: Phản ứng tuberculin chuyển dương là yếu tố căn bản có giá trị. X-quang phổi có hình ảnh điển hình phức hợp nguyên thủy hoặc phì đại hạch trung thất, nặng hơn kèm theo xẹp phổi.

Đây là những yếu tố cơ bản giúp chẩn đoán lao sơ nhiễm mà bác sĩ tuyến huyện có thể thực hiện được, chẩn đoán sớm được cho bệnh nhân tránh những biến chứng xảy ra do chẩn đoán muộn.

9.2. Chẩn đoán phân biệt:

- Phế quản phế viêm lao do tạp khuẩn: Sốt cao kèm dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc, xét nghiệm bạch cầu tăng cao, phổi nghe nhiều rale ẩm, đáp ứng với kháng sinh thông thường.

- Viêm hạch trung thất do vi khuẩn, virus, do ung thư phế quản.

- Nhiễm trùng huyết, sốt rét, thương hàn.

- Phì đại tuyến ức hay u tuyến ức: Bóng mờ rõ có chia múi, 50% có biểu hiện nhược cơ.

10. Điều trị:

Điều trị lao sơ nhiễm cần phải điều trị toàn diện, song song với điều trị thuốc lao đặc trị cần chú ý điều trị bệnh đi kèm, chế độ dinh dưỡng thật tốt.

10.1. Thuốc điều trị lao:

- Dùng phác đồ **A2**: **2RHZE/4RH**

- Điều trị triệu chứng: Chỉ định prednisolon 1mg/kg cho thể có hạch to. Tuy nhiên, chống chỉ định những trường hợp lây từ nguồn lây kháng thuốc.

10.2. Khi điều trị lao cho trẻ em không nên quên trẻ còn mắc các bệnh khác. Những bệnh đó cần phải được điều trị để giúp trẻ phục hồi sức khỏe chung như

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

sốt rét, nhiễm giun sán, nhiễm khuẩn hô hấp trên, mụn nhọt, tiêu chảy, chảy máu...

10.3. Thức ăn và nuôi dưỡng:

Bệnh lao và suy dinh dưỡng là bệnh đồng hành thường đi đôi với nhau. Do bệnh lao gầy sút, sút cân đi kèm mệt mỏi, ăn uống kém làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và sự lan tràn của bệnh lao cho nên vấn đề dinh dưỡng rất cần thiết, nhất là trẻ em. Chế độ ăn trẻ cần nhiều calo, tăng protid, giàu vitamin và khoáng chất.

11. Phòng bệnh:

Muốn trẻ không bị lao sơ nhiễm, không bị biến chứng nặng nề, cần có ngay những biện pháp:

- Chủng ngừa BCG cho trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi (lồng ghép trong chương trình tiêm chủng mở rộng)
- Phát hiện và điều trị nguồn lây
- Tích cực điều trị các bệnh nhiễm trùng.
- Giải quyết tốt vệ sinh môi trường và dinh dưỡng.
- Giảm các yếu tố độc hại.
- Chăm sóc tốt trẻ em, nuôi dưỡng tốt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đỗ Đức Hiển, Bệnh học lao và bệnh phổi, NXB Y học, Hà Nội 1994.
2. Nguyễn Đức Khoan, Bệnh học lao và bệnh phổi, NXB Y học, Hà Nội 1999.
3. Tôn Thất Văn, Kế Hoạch Bài Giảng Và Bài giảng, NXB Y học, Hà Nội 1999.
4. Phạm Long Trung, Bệnh học lao phổi, NXB Đà Năng, 2000.
5. Bệnh học lao, NXB Y học, 2002.
6. Bệnh học lao, GS.TS. Trần Văn Sáng, NXB Y học, Hà Nội 2007.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

LAO PHỔI

A. HÀNH CHÍNH

1. Tên môn học: Bệnh lao
2. Tên tài liệu học tập: Lao phổi
3. Bài giảng: Lý thuyết
4. Số tiết: 2 tiết
5. Đối tượng sinh viên: Y5 hệ 6 năm
6. Địa điểm giảng: Giảng đường

B. MỤC TIÊU

1.Nêu được tầm quan trọng của bệnh lao phổi trong bệnh học lao.

2. Trình bày được các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàngcủa bệnh lao phổi.

3. Trình bày được các thể lâm sàng của bệnh lao phổi.

4. Nêu được các biến chứng của bệnh lao phổi.

5. Trình bày được cách điều trị và phòng bệnh lao phổi.

C. NỘI DUNG

1. Đại cương:

Lao là một bệnh truyền nhiễm do vi trùng lao gây ra (Mycobacterium tuberculosis), vi khuẩn thường xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, từ ổ khu trú ban đầu ở phổi, vi khuẩn lao qua đường máu, bạch huyết, đường hô hấp gây ra bệnh lao ở nhiều cơ quan khác nhau, trong đó lao phổi là thể bệnh phổ biến nhất chiếm từ 80 – 85 % các bệnh lao và đây cũng là thể bệnh duy nhất lây cho người xung quanh bằng khạc đàm có vi trùng lao. Đây là nguồn lây phổ biến khiến bệnh lao tồn tại và phát triển. Chính vì vậy ta cần phải hiểu rõ hơn về bệnh lao phổi để hợp tác với chương trình chống lao quốc gia, hạn chế lao trong cộng đồng.

2. Dịch tễ học:

2.1. Tình hình lao phổi thế giới và Việt Nam:

Theo báo cáo của WHO năm 2001, Việt Nam đứng hàng thứ 11 trong 22 nước có lưu hành lao trên thế giới và cũng là một trong mười nước thuộc châu Á có số bệnh nhân lao lưu hành cao. Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Phillipin về số bệnh nhân lao.

Theo số liệu ước tính của Viện Lao bệnh phổi – Chương trình chống lao quốc gia phối hợp với WHO năm 2000, hiện nay nguy cơ nhiễm lao chung của Việt Nam R = 1,7%(R:Rick). Theo chỉ số này thì nước ta hàng năm có số bệnh nhân lao mới mắc là:

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Tổng số bệnh lao mới mắc ở mọi thể là 145.000 người (tương đương 189/100.000 dân).

- Tổng số bệnh nhân lao AFB(+) mới là 65.000 (tương đương 85/100.000 dân).

Theo số liệu của WHO: Hiện nay,1/3 dân số thế giới đã bị nhiễm lao (1,9-2 tỷ người), 30 triệu người mang bệnh lao phổi tiến triển. Hàng năm lại có thêm 9 -10 triệu người mắc lao, khoảng 3 triệu người chết do căn bệnh này, trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em. Khoảng 95% số bệnh nhân mới và 99% số người chết do lao thuộc các nước đang phát triển. Có khoảng 70% số bệnh nhân lao trên thế giới thuộc các nước châu Á. Trong đó 10 nước có số bệnh nhân lao cao nhất châu Á gồm: Bangladesh, Campuchia,Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, Pakistan, Philipin, Thái Lan và Việt Nam.

Mức độ nặng nề của bệnh lao đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập quốc dân và chỉ số phát triển con người của các quốc gia. Bệnh lao là kết quả của sự đói nghèo và đói nghèo làm cho bệnh lao phát triển. Cho nên vấn đề phát hiện sớm, điều trị kịp thời lao phổi là giúp hạn chế sự lây lan của lao phổi trong cộng đồng.

2.2. Tuổi và giới:

Lao phổi là dạng lao thứ phát thường gặp ở người lớn, thường ở tuổi thanh niên từ 20 – 30 tuổi và người già tỷ lệ cao hơn. Trẻ em ít gặp (6 – 10%) thường lứa tuổi từ 5 – 6 trở lên. Tỷ lệ mắc lao ở người trên 50 tuổi cao hơn rất nhiều so với lớp người dưới 20 tuổi từ 10 – 20 lần. Ở mọi lứa tuổi thì nam mắc lao có tỷ lệ cao hơn nữ. Nữ giới mắc lao nhiều nhất ở lứa tuổi sinh đẻ nhất là sau khi sinh, khi hết tuổi sinh đẻ thì tỷ lệ lao ở nữ giới mới giảm nhanh.

2.3. Phân bố địa dư:

Trong thành phố tỷ lệ mắc lao cao hơn từ 10 – 50% so với nông thôn. Tình hình lao ở miền núi thấp hơn miền xuôi, trong nhà máy tỷ lệ mắc lao cao hơn so với cơ quan từ 1-6 lần.

2.4. Các yếu tố nguy cơ:

- Những yếu tố độc hại làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể: rượu, thuốc lá, dùng thuốc giảm miễn dịch, thuốc chống ung thư, thuốc chứa corticoid.

- Một số bệnh làm nguy cơ mắc lao cao: Đái tháo đường, loét dạ dày tá tràng, bệnh bụi phổi, nhiễm virus, cúm, sởi. Một số bệnh khác có thể ảnh hưởng đến việc mắc lao như: sốt rét mạn tính, nhiễm giun sán, phụ nữ có thai, sinh đẻ nhiều lần...

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

-Nghèo đói và suy dinh dưỡng làm giảm sức đề kháng của cơ thể là nguyên nhân xã hội nghiêm trọng làm cho dễ mắc lao. Những nước mà người dân có nguồn thu nhập kinh tế thấp, những nước đang phát triển, những nước đói nghèo là những nước có tỷ lệ nhiễm lao và bệnh lao cao hơn những nước công nghiệp phát triển.

- Điều kiện sinh hoạt và lao động: Làm việc nặng nhọc, gắng sức, thiếu ăn, nhà cửa chật chội, môi trường ô nhiễm, kém vệ sinh dễ tạo điều kiện cho lây nhiễm.

- Ảnh hưởng một số yếu tố tiêu cực về tâm lý cũng được nêu trong căn nguyên hình thành bệnh lao.

- Người ta thấy những người bình thường và bệnh nhân lao có một sự chênh lệch rất rõ về tỷ lệ số người có chấn thương tình cảm (gia đình bất hạnh, mất mát người thân).

- Một số yếu tố di truyền: Theo Edward Lydin thì tỷ lệ mắc lao tăng theo chiều cao và giảm theo cân nặng. Điều này đã chứng minh một nhận xét dân gian từ lâu đời là người gầy dễ mắc lao hơn người béo.

3. Cơ chế bệnh sinh:

- Nguyên nhân chủ yếu của lao phổi: Do vi khuẩn lao người (Mycobacterium tuberculosis hominis).

- Đường lây bệnh của lao phổi: Đường máu và đường bạch huyết nhưng cũng có trường hợp là đường phế quản.

- Về sinh bệnh học: lao phổi là lao thứ phát sau lao sơ nhiễm. Nguồn gốc của BK có thể từ ngoài vào (bội nhiễm ngoại sinh) nhưng hay gặp là từ tổn thương cũ đã có sẵn trong cơ thể(tái hoạt nội sinh).

+ Tái hoạt nội sinh: TK lao ngủ trong tổn thương sơ nhiễm cũ đã vôi hóa hoặc những nốt lao nguyên thủy dưới dạng tiềm ẩn cứng tự hóa mềm trở nên thuận lợi cho sự sinh sản của vi trùng lao để gây nên lao phổi khi cơ thể bị suy giảm miễn dịch.

+ Bội nhiễm ngoại sinh: Mắc lao phổi do nhiễm trùng lao mới sau khi lao sơ nhiễm đã khỏi. TK lao đột nhập thêm vào cơ thể sẵn có những nốt lao, làm xuất hiện thêm các nốt lao mới ở phổi, TK lao từ nguồn lây bệnh vào cơ thể và gây bệnh. Bội nhiễm ngoại sinh cũng là cơ chế sinh bệnh thường gặp ở các nước dịch tễ lao còn cao.

- Vị trí tổn thương lao phổi thường gặp nhất lúc bắt đầu là vùng đỉnh và vùng dưới đòn (Phần thùy đỉnh và phân thùy sau của thùy trên) và phân thùy đỉnh của thùy dưới. Cơ chế của hiện tượng này được giải thích do:

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

+ Phân áp Oxy ở vùng đó cao(P/O_2 từ 120 – 130 mmHg khi đứng), tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn.

+ Gradient (khuynh độ) lớn của áp suất huyết động ở vùng này so với áp suất thất phải nên có sự chậm lại của luồng máu tạo điều kiện cho TK lao có thể dễ dàng dừng lại gây tổn thương.

4. Giải phẫu bệnh:

Tổn thương cơ bản là viêm phế nang do vi khuẩn lao. Đó là quá trình viêm xuất tiết và có chiều hướng đưa đến bã đậu. Quá trình bã đậu hóa của tổn thương lao được bắt đầu từ vùng trung tâm ra phía xung quanh và dần dần xuất hiện hang lao tập trung thành từng đám, có bờ rõ hoặc hình thành nốt hay củ lao. Hang lao và củ bã đậu là những tổn thương kinh điển và phổ biến trong lao phổi.

4.1. Hang lao:

Có thể chỉ một hang, co khi 2 – 3 hoặc nhiều hơn. Đường kính khoảng từ 2 – 5 cm, có trường hợp to hơn hoặc nhỏ hơn. Vị trí thường gặp là phân thùy đỉnh và phân thùy sau của thùy trên và phân thùy đỉnh của thùy dưới. Hang được bao bọc bởi một thành mỏng, dày mỏng khác nhau tùy theo quá trình thành. Hang lao gồm 3 lớp từ trong ra ngoài là:

- Lớp bã đậu: Còn gọi là màng sinh mủ, trong đó có chứa nhiều vi trùng lao.

- Lớp giữa: Gọi là lớp vỏ hang lao. Trong lớp vỏ hang có nhiều đại thực bào nhiều lớp xơ non, các mạch máu đó là tổ chức hạt dễ đưa tới xơ hóa.

- Lớp ngoại vi: Bao gồm hiện tượng xẹp phế nang ở quanh hang và phản ứng viêm.

4.2. Củ bã đậu:

Kích thước củ bã đậu từ 5 mm đến 2 – 3 cm đường kính. Diễn biến củ bã đậu qua nhiều giai đoạn có củ vôi hóa, có củ thạch hóa. Với hóa trị liệu, các củ lao dù đã vôi hóa vẫn còn có thể tồn tại ổ bã đậu, còn BK và vẫn có thể tái triển.

Các tổn thương đặc hiệu trên kết hợp với các tổn thương không đặc hiệu tạo nên những tổn thương hỗn hợp phức tạp co kéo có thể hủy hoại cả phổi.

5. Lâm sàng:

Đặc điểm lâm sàng của lao phổi diễn biến rất đa dạng, các triệu chứng ở giai đoạn đầu thường kín đáo kéo dài xen kẽ có những đợt tiến triển do đó cần lưu ý để chẩn đoán sớm. Có nhiều thể lâm sàng của bệnh lao phổi.

- Lao kê ở phổi.
- Phế viêm lao.
- Phế quản phế viêm lao.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Lao phổi AFB(+).
- Lao phổi AFB(-).

Tùy theo từng thể mà biểu hiện lâm sàng khác nhau, có 3 hình thức khởi phát bệnh:

- Thể cấp tính (Khoảng 10%): Gặp trong lao kê, phế viêm lao, phế quản phế viêm lao. Bệnh thường xảy ra đột ngột, triệu chứng lâm sàng rầm rộ tiến triển nhanh rất dễ nhầm bệnh cảnh viêm phổi, cúm, sốt rét; khởi bệnh đột ngột, sốt cao 39 – 40°C, rét run, đau ngực, ho khạc ra đàm vàng hoặc bã đậu, hoặc ho khan, ho ra máu ít xảy ra sớm nếu có cần nghĩ nhiều đến lao. Chú ý hỏi bệnh sử sẽ phát hiện những triệu chứng khởi đầu của lao trong vài tuần hoặc vài tháng trước như sụt cân, mệt mỏi, biếng ăn.

+ Bệnh cảnh giả cúm: Sốt nhức mỏi toàn thận, nhức đầu kèm triệu chứng hô hấp nhưng không có triệu chứng mũi họng, sốt kéo dài và tái lập sau một thời gian lui bệnh.

+ Bệnh cảnh viêm phế quản: Ho khạc kéo dài, sốt tái đi tái lại nhiều lần trong tuần lễ liên tiếp, sự tái lập này có thể xảy ra ở một người hoàn toàn khỏe mạnh từ trước tới nay. Do vậy, ở các thể sốt cấp tính có thời gian tiền triệu chứng (triệu chứng nhiễm lao), triệu chứng bệnh không rõ ràng, diễn biến kéo dài thì phải tìm nguyên nhân lao.

- Thể bán cấp: Thường hay gặp lao phổi AFB(+) (chiếm 60 – 75% lao phổi), triệu chứng lâm sàng xuất hiện từ từ, tiến triển kéo dài, thường có nhiều triệu chứng phối hợp và tăng dần. Triệu chứng cơ năng: Ho khạc đàm kéo dài trên 3 tuần.

+ Ho: Đầu tiên ho khan, ho dai dẳng, thường nhiều vào buổi sáng nhưng không cố định giờ giấc, sau đó là ho khạc.

+ Khạc đàm: Thường sau cơn ho, có thể là riêng rẽ, lúc đầu thường là đàm nhớt, có thể có mủ. Ban đầu khạc đàm vào buổi sáng do đó thường nghĩ đến nguyên nhân là thuốc lá nhưng sau đó thì không còn giờ giấc nhất định. Lượng đàm tăng nhiều và trở thành mủ, gợi ý đến hang lao.

Ho và khạc là hai triệu chứng chính gặp trong 90% các trường hợp đưa đến nguy cơ lan tràn bệnh.

+ Ho ra máu: Máu đỏ tươi thường có đuôi, lượng máu ít do tổn thương nhỏ, lượng máu nhiều do tổn thương rộng, có hang to gần rốn phổi. Ho ra máu là một triệu chứng biểu lộ quan trọng khoảng 10% các trường hợp bắt đầu bằng ho ra máu đột ngột.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

+ Đau ngực: Thường đau ngực tương ứng với bên bị tổn thương, có thể đau ngực ít nhiều, khu trú ở 1 vị trí cố định, nhưng thất thường lúc có lúc không.

Triệu chứng tổng quát:

+ Mệt mỏi: Lúc đầu mệt mỏi tinh thần sau đó là thể xác, không giảm khi nằm nghỉ, tăng nhiều vào buổi chiều và dai dẳng.

+ Sút cân: Ăn uống được nhưng sụt cân.

+ Sốt nhẹ không đều, tăng khi làm việc nhiều, giảm khi nghỉ ngơi, thường không gây khó chịu nên người bệnh ít để ý đến, có thể có toát mồ hôi ban đêm.

+ Niêm mạc da thường xanh, nhợt nhạt kèm rối loạn tiêu hóa.

Triệu chứng thực thể thường nghèo nàn ở giai đoạn đầu, có thể nghe được tiếng ral ẩm, nổ nơi tổn thương phổi (song song với vị trí đau ngực).

- **Thể tiềm tàng:** Ít gặp (10%), đó là lao phổi AFB(-), người bệnh trong có vẻ khỏe mạnh, thực ra hỏi kỹ những người này đã có 1 thời gian có triệu chứng mắc lao trên (sốt về chiều, ho, sụt cân...), vì vậy cần phải tìm thêm nguồn lây.

+ Khám định kỳ những đối tượng có nguy cơ cao bị nhiễm lao như lao cũ, tiểu đường, cắt dạ dày, bệnh nhân đã điều trị với thuốc giảm miễn dịch, sau những đợt nhiễm trùng cấp, tiếp xúc với nguồn lây.

+ Khám sức khỏe theo hệ thống.

Nói chung, các dấu hiệu của lao phổi thể hiện ban đầu rất đa dạng, dễ làm ta không để ý đến, bỏ qua hoặc dễ nhầm với các bệnh phổi khác. Tuy nhiên, có một số triệu chứng rất quý báu nghi ngờ đến lao phổi như sốt kéo dài, ho khạc đàm kéo dài (Thường ho dai dẳng trên 3 tuần lễ không rõ nguyên nhân), ho ra máu, đau ngực, sút cân. Khi đó, cần cấy đàm làm xét nghiệm vi khuẩn lao là biện pháp tốt nhất phát hiện lao sớm.

Ở Việt Nam, biểu lộ triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân lao phổi (theo Phạm Văn Chấn, 1997) là:

- Ho khạc: 98%
- Sốt: 64,3%
- Đau ngực: 37,62%
- Mệt mỏi, ăn kém: 27,74%
- Gầy sút: 21,78%.

6. Cận lâm sàng:

6.1. Xét nghiệm đàm:

- Phương pháp soi kính hiển vi trực tiếp:

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

Trong chẩn đoán lao phổi ở cộng đồng thường làm 3 mẫu đàm với trường hợp trên phim X-quang phổi có hang lao. Chẩn đoán lao phổi khi có 2 mẫu đàm dương tính.

Phương pháp này chỉ dương tính khi số lượng TK lao tối thiểu 5000/ml đàm. Phương pháp này chỉ phát hiện vi khuẩn kháng acid (quy định ký hiệu là AFB – Acid fast Bicilli). Việc định danh vi khuẩn phải dựa vào nuôi cấy và định danh vi khuẩn.

- Nuôi cấy:

Phương pháp nuôi cấy là xét nghiệm ít phổ biến trong thực tế vì cần đòi hỏi trang thiết bị, cơ sở xét nghiệm. Hơn nữa xét nghiệm nuôi cấy cho kết quả chậm, chỉ làm nuôi cấy cho các trường hợp thất bại điều trị để làm kháng sinh đồ tìm hiểu sự kháng thuốc của vi khuẩn.

Để phát hiện trực khuẩn lao trong bệnh lao phổi và xác định đặc điểm của mycobacterium gây bệnh, nuôi cấy là phương pháp có độ nhạy khá cao so với khả năng tìm TK lao hai lần soi trực tiếp, còn là phương pháp xác định độ nhạy của vi khuẩn kháng thuốc lao.

Nhược điểm chủ yếu là vi khuẩn lao mọc chậm sau khi nuôi cấy: 4 tuần, môi trường thường dùng là môi trường Loewenstein – Jensen.

Ngày nay người ta có thể nuôi cấy ở môi trường lỏng (hệ thống Bactec) để phát hiện nhanh vi khuẩn trung bình 9 ngày đối với TK lao mà soi trực tiếp dương tính, 16 ngày đối với đàm soi trực tiếp âm tính. Tuy nhiên do giá thành cao và phải xóa cặn bã đồng vị phóng xạ, bởi vậy việc ứng dụng chưa rộng rãi.

6.2. X-quang:

Để theo dõi cần so sánh nhiều phim ở những thời gian khác nhau, thường chụp 2 – 3 phim, khi bắt đầu điều trị, sau điều trị tấn công và ngưng điều trị. Hình ảnh X-quang thường gặp trong lao phổi: Hạt kê, nốt, thâm nhiễm, hang, dải xơ.

- Hạt kê: là những hạt mờ kích thước đồng đều từ 1 – 3 mm tròn, ít đậm, bờ không rõ đều khắp ở hai phế trường, đó là hình ảnh của lao kê.

- Nốt: Là bong mờ có kích thước không đồng đều, đường kính nốt trung bình 5 – 7 mm, thường 3 – 10mm, thường bờ rõ tập trung thành từng đám đứng ở cạnh tim hoặc rải rác 2 phổi, thường gặp trong phế quản phế viêm lao.

- Thâm nhiễm: Thường là đám mờ, kích thước lớn hơn 1 cm, mờ không đồng nhất, giới hạn không rõ, không gây ảnh hưởng các bộ phận xung quanh, vị trí thường gặp ở đỉnh phổi và dưới đòn.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Hang lao: Trên X-quang là một hình sáng được giới hạn rõ rệt bởi một bờ cản quang không đứt quãng, X-quang đậm, thường ở thùy trên, kích thước hang to nhỏ khác nhau, trung bình đường kính từ 2 – 5 cm.

- Dải xơ: Dải mờ đường kính bất kỳ, chiều dài bất kỳ gây co kéo các bộ phận xung quanh như khí quản, tim, vòm hoành...

Ngoài ra có thể gặp một số hình ảnh khác như: Rối loạn thông khí do phế viêm lao giai đoạn đầu (đó là đám mờ đồng nhất hình tam giác đỉnh quay vào trong). Có thể trên một bệnh nhân lao phổi có một lúc nhiều hình ảnh tổn thương như trên.

Hình ảnh X-quang không định bệnh được nhưng cho ta biết tính chất sang thương, đánh giá được tiên lượng bệnh.

6.3. Các xét nghiệm khác:

- Phản ứng tuberculin: Dương tính mức độ trung bình, có thể âm tính trong lao kê, phế viêm lao, phế quản phế viêm lao. Nếu lao phổi AFB(-) phản ứng tuberculin dương tính cũng có vai trò giúp định hướng chẩn đoán.

- Công thức máu: Có thể tăng 10-15.000 BC/mm^3, N tăng cao trong lao kê, phế quản phế viêm lao, phế viêm lao. Thường giới hạn bình thường, với tỷ lệ lymphocyte tăng, VS tăng cao.

7. Chẩn đoán lao phổi:

7.1. Chẩn đoán xác định:

Muốn chẩn đoán xác định lao phổi cần dựa trên nhiều yếu tố lâm sàng, X-quang phổi, xét nghiệm đàm, các xét nghiệm khác đối chiếu tiền sử, bệnh sử và hoàn cảnh xã hội của bệnh nhân, hệ thống hóa các yếu tố đó lại để có một chẩn đoán chính xác cụ thể.

- Khám lâm sàng:

+ Hỏi bệnh sử: Giai đoạn đầu tiên của khám lâm sàng chú trọng đến các điểm sau: Chủng ngừa BCG chưa (nếu còn nhỏ)?Triệu chứng lao sơ nhiễm trước đó: mệt mỏi, gầy sút, ho... Bệnh lao cũ: thời gian, thuốc điều trị trước đó với đầy đủ các giai đoạn điều trị cũng như liều lượng thuốc; Nguồn lây; điều kiện sinh sống của gia đình và nghề nghiệp.

+ Khám thực thể: Các triệu chứng lâm sàng của lao phổi đều không đặc hiệu nhưng cần được coi trọng vì chính những triệu chứng đó giúp ta tìm các yếu tố khác để xác định chẩn đoán, nhất là giúp phát hiện sớm bệnh.

- X-quang cho biết một số đặc điểm về tổn thương phổi nhưng không cho biết nguyên nhân của tổn thương đó, phải tìm được TK lao mới xác định nguyên nhân do lao.

*** Đối với tuyến cơ sở:** Muốn chẩn đoán lao phổi dựa vào:

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Lâm sàng: Các triệu chứng nghi ngờ lao như ho khạc đàm kéo dài trên 3 tuần, ho ra máu, đau ngực, sụt cân, sốt nhẹ hoặc sốt cao.

- Làm xét nghiệm đàm soi trực tiếp 3 mẫu cho tất cả các đối tượng có triệu chứng nghi ngờ trên tại tuyến cơ sở.

Còn khi AFB (-) tuyến cơ sở có thể chuyển bệnh nhân lên tuyến huyện, tuyến tỉnh làm thêm X-quang phổi, phản ứng tuberculin: Nếu dương tính giúp định hướng chẩn đoán (vì trong điều kiện nước ta, bệnh lao có tỷ lệ lưu hành cao, phản ứng này có giá trị biểu hiện tình trạng đã và đang bị nhiễm vi khuẩn lao).

Còn với tuyến huyện, tuyến tỉnh: Chụp X-quang có giá trị bổ sung chẩn đoán khi đã có một xét nghiệm đàm AFB(+).

7.2. Chẩn đoán phân biệt:

Chẩn đoán phân biệt cần đặt ra trong những trường hợp lao phổi AFB(-) trong đàm. Trên thực tế cần phân biệt với các bệnh sau:

- Viêm phổi do vi khuẩn.
- Viêm phổi do virus và các vi khuẩn liên kết (mycoplasma rickettsia).
- Ung thư phế quản phổi.
- Bệnh bụi phổi.
- Giãn phế quản.
- Viêm phế quản mạn.
- Bệnh ký sinh trùng phổi, hội chứng loeffler amip phổi, sán lá phổi, nấm phổi (chủ yếu là nấm Arpergillus bội nhiễm trong long một hang lao đã khỏi).

8. Các thể lâm sàng của lao phổi:

8.1. Lao phổi AFB(+):

Khi chẩn đoán lao phổi AFB(+) cần phải có một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tối thiểu có hai tiêu bản xét nghiệm AFB(+) từ hai mẫu đàm khác nhau.
- Một tiêu bản có AFB(+) và có hình ảnh nghi lao trên phim X-quang.
- Một tiêu bản AFB(+) và nuôi cấy dương tính.

8.2. Lao phổi AFB(-):

Kết quả xét nghiệm đàm AFB(-) ít nhất 6 mẫu đàm khác nhau, qua 2 lần khám cách nhau từ 2 tuần đến 1 tháng và có tổn thương nghi lao trên phim X-quang phổi. Được BS chuyên khoa lao (chương trình chống lao tỉnh) hội chẩn và nghĩ đến bệnh lao.

8.3. Lao kê ở phổi:

Đây là thể lao phổi cấp tính (biến chứng sau lao sơ nhiễm ở trẻ không được chủng ngừa BCG), thường gặp nhiều ở trẻ em, ngày nay đại dịch HIV lan tràn, lao kê ở phổi có xu hướng tăng ở người lớn.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Lâm sàng: Thường biểu hiện cấp tính với triệu chứng nghèo nàn như sốt cao, có thể kèm ho khan hoặc không, rất dễ nhầm với nhiễm trùng huyết, thương hàn, sốt rét.

- Cận lâm sàng: Phản ứng tuberculin có thể âm tính, X-quang phổi có hình ảnh đặc trưng là hạt lao kê đều, kích thước 1 – 3mm nằm rải rác đều 2 bên phổi. Xét nghiệm máu bạch cầu tăng, nếu chẩn đoán muộn sau 3 – 4 tuần dễ tử vong. Song song lao kê có thể biểu hiện triệu chứng lao màng não đi kèm (thường sau lao kê 2 tuần).

8.4. Phế viêm lao:

Hay còn gọi là viêm phổi lao. Đây là thể lao phổi cấp tính hay gặp ở tuổi thanh niên, biểu hiện gần giống viêm phổi thùy do vi khuẩn như sốt cao đột ngột, lạnh run, đau tức ngực nhiều, ho khạc đàm vàng. Khám thực thể có hội chứng đông đặc một phân thùy phổi, ran nổ. X-quang phổi có hình ảnh viêm phổi thùy mờ đồng nhất hình tam giác đỉnh quay vào trong. Xét nghiệm máu: Bạch cầu tăng cao, Neutrophyl cao 80 -90%.

Nếu không được chẩn đoán sớm, sau khoảng 2 – 3 tuần, bệnh nhân bắt đầu khạc đàm bã đậu, có thể có máu, đàm có rất nhiều trực khuẩn lao. Xét nghiệm đàm giai đoạn này AFB(+) cao là nguồn lây lan cho cộng đồng. X-quang phổi có nhiều hang lao, dải xơ ở một phân thùy co kéo trung thất, khí quản về phía tổn thương. Di chứng này là vĩnh viễn, ảnh hưởng tới chức năng hô hấp của bệnh nhân. Nếu không được phát hiện sớm, bệnh nhân tử vong trong vòng 3 – 4 tuần do suy kiệt, ho ra máu sét đánh.

8.5. Phế quản phế viêm lao:

Đây là biểu hiện **cấp tính rất nặng** của lao phổi. Tổn thương lao ở nhiều nơi viêm phế nang, phế quản và rải rác 2 phổi. Hay gặp ở trẻ em bị lao sơ nhiễm với hạch trung thất lớn sau đó dò ra gieo rắc bã đậu vào mô phổi hoặc gặp ở người lớn già yếu.

- Triệu chứng lâm sàng: Sốt dao động, sút cân, tiêu chảy, ho khạc nhiều đàm có bã đậu (nhiều BK, đau tức ngực, khó thở, ho ra máu chiếm 10 – 20 %), khám gõ đục từng vùng, rung thanh tăng có tiếng thổi hang, rale ẩm to nhỏ hạt.

- X-quang phổi: Hình mờ không đồng đều, thâm nhiễm rải rác 2 phế trường, hang lao ở đáy...

- Xét nghiệm đàm AFB(+), bạch cầu tăng cao, N tăng, VS tăng. Nếu không được chẩn đoán sớm bệnh nhân dễ tử vong vì suy kiệt, ho ra máu...

9. Tiến triển và biến chứng:

9.1. Lành bệnh:

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

Đạt được nhờ phối hợp thuốc kháng lao, được xác nhận không có vi trùng lao trong đàm, âm tính thường trực và vĩnh viễn. Trên X-quang có thể còn những di chứng của lao như nốt vôi, hang lao, co kéo. Khả năng lành bệnh 95 – 100%, nhưng mức độ tái phát 2 – 3 %.

9.2. Tiến triển hiện nay của lao phổi:

Tùy thuộc ít nhiều theo diễn biến lúc khởi bệnh và một phần tùy thuộc vào cơ địa. Tiến triển tùy thuộc thực sự vào yếu tố chính: nhóm bệnh mới hoặc cũ và chất lượng điều trị.

- Trường hợp đặc biệt:

+ Lao kê: Nếu chẩn đoán trễ, điều trị không kịp thời có thể tử vong sau 3 - 4 tuần.

+ Phế quản phế viêm lao, phế viêm lao: Nếu chẩn đoán trễ dẫn đến hoại tử bã đậu tạo hang, giai đoạn này ra nhiều BK sẽ tử vong trong 3 – 4 tuần do suy kiệt, bội nhiễm, ho ra máu sét đánh, trụy mạch...

+ Thể tối cấp đưa đến tử vong sớm ở những bệnh quá trẻ (dưới 1 tuổi) hay quá già có các bệnh khác kèm theo.

+ Cơ địa bệnh nhân sẽ tạo ra những tiến triển khá phức tạp. Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể, tinh thần và xã hội làm cho bệnh nhân không theo dõi điều trị đúng. Ở những người nghiện rượu rất dễ nhiễm trùng, người suy dinh dưỡng, thiếu protein, thiếu vitamin, xơ gan sẽ làm rối loạn tiến triển ở người tiểu đường, cắt da dày là những yếu tố gây khó khăn cho việc điều trị. Người già, người di cư kém hiểu biết và kém hợp tác trong điều trị là hai yếu tố làm giảm hiệu quả điều trị.

9.3. Tiến triển đến di chứng giải phẫu, biến chứng nếu được điều trị muộn, điều trị dai dẳng:

- Ho ra máu.
- Tràn khí màng phổi.
- Tràn dịch tràn mủ màng phổi.
- Lao thanh quản.
- Di chứng phế quản khu trú với khả năng bội nhiễm lặp đi lặp lại nhiều lần.
- Nấm Aspergillus phổi mọc trên các ổ lao cũ là nguyên nhân ho ra máu tái lập nhiều lần, cho nên cần tìm nấm một cách kỹ lưỡng và nhiều lần ở những bệnh nhân mà trên X-quang còn có hình ảnh hang.
- Lao kê: Đi kèm lao màng não để di chứng màng não.

10. Điều trị:

10.1. Mục đích của điều trị:

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Điều trị khỏi bệnh với ảnh hưởng tối thiểu đến cuộc sống bệnh nhân.
- Phòng tử vong trong những trường hợp nặng.
- Phòng phổi bị hủy hoại thêm với hậu quả kèm theo.
- Tránh tái phát.
- Tránh tạo ra vi khuẩn kháng thuốc (kháng thuốc thứ phát).
- Bảo vệ cho gia đình bệnh nhân và cộng đồng.

10.2. Điều trị nguyên nhân:

Điều trị nội khoa là chủ yếu. Hóa trị liệu lao ngắn ngày là biện pháp cơ bản để điều trị lao phổi cho bệnh nhân mới điều trị lần đầu. Dùng các thuốc kháng lao theo đúng nguyên tắc điều trị (phối hợp thuốc, đúng liều, đủ thời gian, liên tục có kiểm soát). Tuy nhiên tùy theo từng thể lao phổi, tùy biến chứng kèm theo mà có cách xử trí khác nhau:

- Lao phổi mới: Dùng phác đồ **A1**: 2RHZE/4RHE
- Nếu lao kê kèm theo lao màng não phải sử dụng phác đồ **B1**: 2RHZE/10RHE, điều trị triệu chứng kèm theo lao màng não.
- Lao trẻ em, phụ nữ có thai dùng phác đồ **A2:** 2RHZE/4RH.
- Ho ra máu đi kèm phải song song điều trị thuốc lao, vừa cầm máu cho bệnh nhân tùy theo đánh giá mức độ. Đây là việc tuyến y tế cơ sở có thể xử lí được, tránh chuyển lên tuyến trên lúc ho ra máu, có thể chuyển lên tuyến trên khi AFB(-) chưa xác định rõ nguyên nhân là lao.

10.3. Chế độ làm việc và sinh hoạt:

Nếu bệnh không quá nặng và bệnh nhân đã được điều trị thì làm việc là vô hại, bắt buộc người lao động chính của gia đình phải nghỉ việc do lao phổi là một sai lầm lớn. Quyết định điều trị nội trú hay ngoại trú cần phải cân nhắc căn cứ trên tính chất nặng nhẹ, theo đường lối chung của chương trình quốc gia và điều kiện kinh tế của gia đình bệnh nhân. Chế độ dinh dưỡng cần hợp lý, nên tăng đạm, tăng calo, giàu sinh tố. Tốt nhất là bỏ thuốc lá, bỏ uống rượu. Sau 2 – 3 tuần điều trị, lao phổi không còn lây nhiễm nữa, không buộc phải cách ly xã hội và các mối quan hệ khác.

10.4. Tổ chức thăm khám người tiếp xúc trong gia đình bệnh nhân lao:

Bệnh nhân lao phổi AFB(+) là nguồn lây chính đặc biệt là lây cho trẻ em. Do đó khi phát hiện bệnh nhân lao phổi AFB đàm (+) cần khám các thành viên trong gia đình để tìm người bị lây. Mặt khác nếu phát hiện được trẻ mắc lao thì cần khám bệnh cho các thành viên trong gia đình để tìm nguồn lây, đặc biệt là cha, mẹ.

11. Phòng bệnh lao phổi trong cộng đồng:

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

Theo WHO, người thầy thuốc có 2 việc để phòng bệnh lao phổi trong cộng đồng, đó là:

- Phát hiện sớm cho được nhiều người ho khạc đàm AFB(+), đó là nguồn lây lao chính. Mục tiêu cụ thể của chương trình chống lao quốc gia đến 2005 là: Phát hiện tối thiểu 75% số bệnh nhân lao phổi AFB(+) mới theo ước tính hiện có trong cộng đồng. Ưu tiên phát hiện nguồn lây chính: Đảm bảo thu nhận tối thiểu từ 70% số bệnh nhân lao phổi AFB(-) trong tổng số bệnh nhân lao được phát hiện.

- Điều trị thật tốt cho các trường hợp đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình chống lao quốc gia đến năm 2005, điều trị khỏi ít nhất 85% số bệnh nhân lao phổi bằng hóa trị liệu ngắn ngày có kiểm soát. Triển khai hóa trị liệu ngắn ngày có kiểm soát trực tiếp 100% bệnh nhân lao được chương trình thu nhận, quản lý, điều trị.

Phát hiện sớm và điều trị kịp thời lao phổi là biện pháp tích cực để phòng biến chứng và di chứng do lao phổi.

Đối với từng cá nhân, muốn phòng lao phải:

- Có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, chế độ dinh dưỡng tốt.

- Nhà cửa thoáng mát, không ẩm thấp. Giữ gìn tốt môi trường sống không ô nhiễm.

- Quản lý và xử lí tốt các chất thải của bệnh nhân lao: Tránh khạc nhổ bừa bãi, tiệt trùng các chất thải.

- Trẻ em phải tiêm phòng BCG.

Phòng bệnh lao phổi tuân thủ theo chiến lược của chương trình chống lao quốc gia đề ra:

- Phát hiện thụ động bằng phương pháp soi trực tiếp là chủ yếu.

- Ưu tiên phát hiện nguồn lây: Lao phổi AFB(+).

- Thực hiện phác đồ hóa trị ngắn ngày có kiểm soát thống nhất trên toàn quốc.

- Thực hiện miễn phí tiền thuốc chống lao.

- Lồng ghép vào hoạt động chung của y tế cơ sở.

-Tiêm Vaccin BCG đầy đủ cho trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi.

- Thống nhất hệ thống ghi chép sổ sách, thống kê báo cáo trên toàn quốc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tập huấn chương trình chống lao của trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Đăk Lăk, năm 2003.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

2. Kế hoạch bài giảng và bài giảng dưới sự hỗ trợ dự án Hà Lan – Việt Nam, Tôn Thất Văn, năm 1999.
3. Bệnh học lao phổi, Phạm Long Trung, NXB Đà Nẵng năm 2000.
4. Bệnh học lao, GS.Trần Văn Sáng, NXB Y học, Hà Nội năm 2007.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

LAO HẠCH

A. HÀNH CHÍNH

1. Tên môn học: Bệnh lao
2. Tên tài liệu học tập: Lao hạch.
3. Bài giảng: Lý thuyết
4. Số tiết: 2 tiết
5. Đối tượng sinh viên: Y5 hệ 6 năm
6. Địa điểm giảng: Giảng đường

B. MỤC TIÊU

1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của lao hạch.
2. Nêu được hai xét nghiệm quan trọng để chẩn đoán xác định lao hạch.
3. Kể được phác đồ điều trị lao hạch trong chương trình điều trị lao hiện nay.

C. NỘI DUNG

1. Đại cương:

Hạch Lympho bị vi trùng lao tấn công tạo phản ứng viêm đặc hiệu trên giải phẫu bệnh là nang lao.

Nang lao là phản ứng đề kháng của hệ lympho đặc biệt để chống lại các loại mycobacterium. Các nang lao này ngoài cùng là vùng lympho rồi tới các tế bào dạng biểu bì xếp hình củ hành bao quanh một vùng trung tâm có tế bào khổng lồ Langhans, vùng trung tâm là chất bã đậu có chứa trực khuẩn lao.

Hạch lympho là một trong những nơi đáp ứng miễn dịch chống lại một kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể.

Lao hạch thường không sốt, tuy nhiên đôi khi có sốt nhẹ hoặc sốt cao. Tiên lượng nói chung tốt nhưng khi dò thì để lại sẹo nhăn nhúm xấu xí.

2. Dịch tễ học:

- Lao hạch là một thể lao ngoài phổi thường gặp, chiếm từ 3 – 5 % trường hợp lao. Vì lao hạch không phải là nguồn lây lan cho xã hội nên không được chú trọng trong dịch tễ học. Thêm nữa, lao hạch cũng không phải là nguyên nhân tử vong trước mắt nên hay bị coi thường. Nhưng hiện nay nhiễm HIV làm tăng tỷ lệ bệnh của lao hạch, người ta nhận thấy rằng 70% bệnh nhân nhiễm HIV có lao hạch phối hợp.
- Lao hạch là một bệnh lý ít ảnh hưởng đến toàn thân nhưng hay để lại di chứng ảnh hưởng đến thẩm mỹ nếu phát hiện muộn.
- Thông thường hạch cổ hay bị lao và chiếm khoảng 80%, hạch nách chiếm 3%, hạch bẹn chiếm 2,6%, hạch nhiều chỗ chiếm 5,4%.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Tuổi mắc bệnh: thường gặp ở trẻ em và người trẻ tuổi. Tuổi từ 15 – 30 chiếm 46,6%.

- Giới: Nữ nhiều hơn nam (82,75% so với 17,25%).

- Điều kiện thuận lợi: Sức khỏe giảm sút, sống trong môi trường ẩm thấp có nguồn lây lao.

3. Sinh lý bệnh và giải phẫu bệnh:

3.1. Sinh lý bệnh:

- Nguyên nhân: Chủ yếu do trực khuẩn lao người.

- Đường lây bệnh: Trực khuẩn lao từ ngoài vào cơ thể, xâm nhập vào đường máu và đường bạch huyết rồi đến hạch và gây tổn thương lao tại hạch.

3.2. Giải phẫu bệnh:

- **Đại thể:** Bắt đầu từ hạch nhỏ, thường nhiều hạch, kích thước bằng hạt ngô, chắc, không dính vào nhau hoặc không dính vào da. Hạch to dần kèm viêm xung quanh hạch hình thành một mảng dính vào nhau và dính vào da, tiếp đến hạch sẽ nhuyễn hóa bã đậu đi đến loét, dò và chảy mủ kéo dài, khi lành sẹo có bờ nham nhỡ xấu xí. Số ít hiếm gặp hơn: hạch to, cứng tuy nhiên có thể thấy bã đậu.

- **Vi thể:** Tổn thương lao điển hình, nang lao với chất bã đậu, các tế bào bán liên, tế bào khổng lồ Langhans, có thể có BK nhưng ít và khó phát hiện. Hạch ở trẻ em thường gặp chất bã đậu, ít gặp nang lao.

4. Lâm sàng:

4.1. Dấu hiệu toàn thân:

Bệnh nhân có thể sốt cao hoặc sốt nhẹ về chiều, nhưng thường không sốt, ra mồ hôi trộm về đêm.

4.2. Dấu hiệu tại hạch:

Hạch lớn là chủ yếu và thường trải qua nhiều giai đoạn:

- Giai đoạn đầu: Một nhóm hạch sưng to riêng rẽ, chắc, không đau, không dính vào tổ chức xung quanh, di động dễ.

- Giai đoạn tiếp: Hạch dính chùm với nhau và dính vào tổ chức xung quanh.

- Giai đoạn sau: Hạch nhuyễn hóa bã đậu, dò mủ tạo ra lỗ dò có bờ mỏng tím tái. Khi mủ khô tạo thành sẹo nhăn nhúm xấu xí. Có trường hợp hạch lớn chắc không làm mủ.

5. Cận lâm sàng:

5.1. Chọc dò và sinh thiết hạch:

Sinh thiết hạch là xét nghiệm có giá trị chẩn đoán lao hạch. Tổn thương điển hình là nang lao với bã đậu. Chọc dò hạch tìm được trực khuẩn lao.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

5.2. Phản ứng mantoux (tuberculin) Thường dương tính mạnh.

5.3. Chụp X-quang phổi: Thường có tổn thương ở phổi và màng phổi kèm theo.

5.4. Xét nghiệm máu: VS thường tăng, công thức máu Lympho tăng.

6. Các thể lâm sàng: Tùy theo đặc điểm và tính chất hạch, có thể có các thể lâm sàng sau:

6.1. Thể lao hạch bã đậu: Thường gặp ở các hạch ngoại biên.

6.2. Thể u hạch lao: Một hạch đơn độc sưng to, cứng, không đau, không di động, không nhuyễn hóa bã đậu.

6.3. Thể viêm nhiều hạch: Thường bắt đầu ở hạch cổ, một hạch sưng to, xung quanh có nhiều hạch nhỏ hơn, di động, không đau, không dính, sau đó xuất hiện hạch ở nách, hạch bẹn, hạch trung thất, hạch mạc treo... Thể trạng bệnh nhân tốt. Chẩn đoán dựa vào chọc hạch và sinh thiết hạch.

6.4. Thể phối hợp: lao hạch phối hợp với các bộ phận khác như lao phổi, lao các màng, lao xương khớp...

7. Tiến triển:

- Nếu được điều trị tốt, hạch sẽ biến mất không để lại dấu vết hoặc để lại di chứng xơ cứng hoặc vôi hóa, nhưng những hạch này không còn nang lao, không cần điều trị ngoại khoa.

- Nếu không được điều trị: Hạch trở nên mãn tính hoặc nổi thêm các hạch khác hoặc dò mủ tạo sẹo xấu xí, hoặc lan đến các bộ phận khác khi có điều kiện thuận lợi gây nên tổn thương lao ở nơi khác.

8. Chẩn đoán:

8.1. Chẩn đoán xác định: Có hai tiêu chuẩn:

- Sinh thiết hạch tìm thấy tổn thương lao điển hình.
- Chọc dò hạch tìm thấy trực khuẩn lao.

Khi không có hai tiêu chuẩn trên có thể dựa vào lâm sàng và tính chất của hạch để chẩn đoán. Ngoài ra cũng cần kết hợp với phản ứng mantoux, tiền sử chưa tiêm chủng BCG, tiền sử nhiễm lao hoặc bị lao. Nếu có tổn thương lao ở các bộ phận khác thì góp phần cho chẩn đoán.

8.2. Chẩn đoán phân biệt:

- Viêm hạch do vi khuẩn: Sưng nóng đỏ đau kèm viêm tấy tổ chức xung quanh hạch, bệnh nhân thường sốt cao. Chọc dò và sinh thiết hạch có nhiều mủ và cấy có vi khuẩn gây bệnh. Bệnh đáp ứng tốt với kháng sinh thông thường.

- **Viêm hạch do virus:** Hạch có sưng to không đau, không di động, chọc hạch không có tổn thương lao, hạch tự hết trong thời gian ngắn (7 ngày).

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- **Hạch to trong các bệnh ác tính:** Leucemie, Hogkin, Ung thư hạch, di căn hạch... chẩn đoán dựa vào chọc và sinh thiết hạch.

9. Điều trị: Tuân theo nguyên tắc điều trị lao chung và điều trị theo phác đồ của chương trình chống lao quốc gia.

- Người lớn: Dùng phác đồ B1:**2RHZE/10RHE.**

- Trẻ em: Dùng phác đồ B2: **2RHZE/10RH (không dùng ethambutol ở trẻ em vì thuốc có thể gây mù màu và trẻ em thì không nói được nên không biết để ngưng thuốc)**

- Corticoid: Chỉ dùng trong giai đoạn đầu khi mới bị viêm hạch, có tác dụng chống viêm. Ngày nay ít sử dụng và có chống chỉ định trong trường hợp lao hach trung thất vì có thể làm nhuyễn hóa bã đậu nhanh và gây tràn ngập cây phế quản, bệnh nhân chết đột ngột.

- Khi hach sâu, dò mủ thì phải điều trị ngoại khoa kết hợp. Hoặc khi đã điều trị kháng lao tích cực kết hợp với corticoid mà vẫn không hiệu quả thì phải phẫu thuật cắt bỏ hạch.

10. Phòng bệnh:

- Chủng ngừa BCG cho trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi.
- Phát hiện sớm và điều trị nguồn lây.
- Vệ sinh môi trường thoáng mát.
- Tránh các yếu tố độc hại.
- Đảm bảo dinh dưỡng tốt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bệnh học lao và bệnh phổi, Phạm Long Trung, NXB Đà Nẵng năm 2000.
2. Bệnh học lao, NXB Y Hà Nội năm 2002.
3. Bệnh học lao, GS.Trần Văn Sáng, NXB y học Hà Nội năm 2007.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

LAO MÀNG PHỔI

A. HÀNH CHÍNH

1. Tên môn học: Bệnh lao
2. Tên tài liệu học tập: Lao màng phổi..
3. Bài giảng: Lý thuyết
4. Số tiết: 2 tiết
5. Đối tượng sinh viên: Y5 hệ 6 năm
6. Địa điểm giảng: Giảng đường

B. MỤC TIÊU

1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao thể tự do.
2. Trình bày được các yếu tố chẩn đoán lao màng phổi.
3. Trình bày được các nguyên tắc điều trị và phòng ngừa lao màng phổi.

C. NỘI DUNG

1. Đại cương:

Lao màng phổi là bệnh ở màng phổi gây ra bởi trực khuẩn lao, đây là bệnh lao thứ phát sau lao sơ nhiễm. Từ năm 1955, Abrám đã tìm ra kim để sinh thiết màng phổi, đã chứng minh một cách rộng rãi những tổn thương lao ở màng phổi khác với các tổn thương lao ở phổi (vì trước đó người ta không phân biệt được một cách rõ ràng lao phổi với lao màng phổi). Lao màng phổi đơn thuần không lây cho cộng đồng, nhưng nếu điều trị muộn dễ để lại di chứng dày dính màng phổi ảnh hưởng nhiều đến chức năng hô hấp của bệnh nhân. Nếu lao màng phổi không được điều trị thì lao phổi sẽ xuất hiện trong 2/3 các trường hợp trong vòng 5 năm. Cho nên vấn đề chẩn đoán sớm, điều trị đúng lao màng phổi rất là cần thiết, giúp tránh được di chứng dày dính màng phổi cho bệnh nhân đồng thời tránh lao ở các cơ quan khác nhất là lao phổi bởi đây là nguồn lây bệnh trong cộng đồng rất lớn.

2. Dịch tễ: Lao màng phổi là thể bệnh phổ biến trên lâm sàng, đứng hàng đầu trong các thể lao ngoài phổi.

- Theo các tác giả thế giới và Việt Nam thì tỷ lệ lao màng phổi trong các thể lao ngoài phổi 25 – 27%.
- Tuổi: mắc bệnh là mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp lứa tuổi trẻ từ 16 – 30 tuổi. Đây là yếu tố quyết định để chẩn đoán nguyên nhân lao của tràn dịch.
- Điều kiện thuận lợi:

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

+ Trẻ em chưa được chủng vaccine phòng lao BCG có tới 70% mắc lao màng phổi.

+ Trẻ bị lao sơ nhiễm nhưng chưa được phát hiện hay phát hiện muộn, hay điều trị không đúng.

+ Những người tiếp xúc thường xuyên, trực tiếp với bệnh lao phổi có AFB(+) trong đàm.

+ Những đợt tiến triển của lao phổi.

+ Nhiễm lạnh đột ngột, làm việc quá sức, ăn uống kém, suy dinh dưỡng.

+ Chấn thương lồng ngực.

3. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh:

3.1. Nguyên nhân: Hay gặp là vi khuẩn lao người, vi khuẩn lao bò và vi khuẩn lao không điển hình ít gặp hơn.

3.2.Đường lây bệnh:

- Đường máu và đường bạch huyết là chủ yếu (BK từ tổn thương tiên phát theo máu và bạch huyết tới màng phổi và gây tổn thương lao tại màng phổi).

- Đường tiếp cận: Tổn thương lao phổi gần lá tạng màng phổi, tiến triển xâm nhập vào màng phổi.

Vì vậy lao màng phổi là lao thứ phát sau lao sơ nhiễm, lao phổi.

4. Giải phẫu bệnh:

4.1. Đại thể:

- Giai đoạn đầu: Màng phổi phù nề, xung huyết, xuất tiết dịch vàng chanh, có thể gặp dịch hồng đục.

- Giai đoạn sau: Màng phổi dày lên, thô ráp, có thể thấy các hạt lao, cục lao nhuyễn hóa bã đậu, nhu mô phổi cạnh màng phổi xẹp.

- Giai đoạn muộn: Dịch màng phổi giảm tiết, lá thành lá tạng dày lên dính vào nhau hoặc dính vào trung thất cơ hoành. Có thể thấy những dải xơ chia khoang màng phổi thành những ổ riêng biệt.

4.2. Vi thể:

- Giai đoạn đầu: Tế bào nội mô màng phổi bị phá hủy, chất sợi tơ huyết (fibrin) lắng đọng lên bề mặt màng phổi tạo màng giả, làm màng phổi dày lên, thấy những tổn thương lao đặc hiệu (nang lao). Dịch màng phổi là dịch tiết nhiều fibrin, nhiều bạch cầu lympho.

- Giai đoạn sau: Xuất hiện tổn thương xơ.

- Giai đoạn muộn: Tổ chức xơ chiếm ưu thế ở màng phổi.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

Qua diễn biến về giải phẫu bệnh lý của tổn thương, chúng ta thấy rằng ở giai đoạn đầu, tiêu bản sinh thiết màng phổi dễ tìm thấy tổn thương lao đặc hiệu (nang lao). Ở giai đoạn muộn, tổn thương trên tiêu bản là viêm xơ.

5. Lâm sàng: Thể điển hình lao màng phổi là tràn dịch tự do màu vàng chanh.

5.1. Giai đoạn khởi phát: Thường kéo dài khoảng 2 – 3 ngày.

- Diễn biến cấp tính: Khoảng 50% các trường hợp có diễn biến cấp tính như đau ngực đột ngột dữ dội, sốt cao 39 – 40°C, khó thở, ho khan.

- Diễn biến từ từ: Khoảng 30% các trường hợp với các dấu hiệu như đau ngực liên tục, sốt nhẹ về chiều và tối, khó thở, ho khan tăng dần.

- Diễn biến tiềm tàng: Dấu hiệu lâm sàng nghèo nàn, kín đáo, thường bị bỏ qua.

- Một số ít bệnh nhân có diễn biến rất trầm trọng giống bệnh cảnh thương hàn.

5.2. Giai đoạn toàn phát:

- Dấu hiệu toàn thân: Bệnh nhân xanh xao mệt mỏi, gầy sút, sốt liên tục, nhiệt độ dao động 38 – 40 ^{o}C, mạch nhanh, huyết áp hạ, buồn nôn, lượng nước tiểu ít.

- Dấu hiệu cơ năng: 2 triệu chứng đáng chú ý nhất là đau ngực, khó thở.

+ Ho khan từng cơn, xuất hiện khi thay đổi tư thế. Nếu có phối hợp lao phổi với có ho khạc đàm.

+ Đau ngực khi thay đổi tư thế, đau ê ẩm ở vùng hông, đau lan lên vai, đau lan ra sau lưng và đôi khi lan xuống hạ sườn phải. Đau tăng khi ho và hít vào sâu, đau ngực cũng làm bệnh nhân khó thở.

+ Khó thở tăng dần, thường xuyên ở cả hai thì, lượng dịch nhiều gây tím môi, co kéo cơ hô hấp.

+ Khi lượng dịch còn ít, bệnh nhân thường nằm nghiêng về bên phổi lành, khi dịch nhiều bệnh nhân nằm nghiêng về bên bệnh hoặc ngồi dựa lưng vào tường để thở.

+ Có thể kèm đau bụng dễ chẩn đoán nhầm bệnh ngoại khoa (do dịch đè cơ hoành).

- Dấu hiệu thực thể: (HC 3 giảm)

+ Nhìn: Lồng ngực bên bệnh vồng lên, di động lồng ngực giảm hơn so với bên lành, khoang gian sườn giãn rộng với bên lành.

+ Sờ: Rung thanh giảm, mất.

+ Gõ: Đục, có thể xác định được giới hạn trên của vùng đục nếu tràn dịch vừa gọi là đường cong damoiseau, còn tràn dịch nhiều gõ đục toàn bộ nữa lồng ngực (hay tràn dịch lượng nhiều bên trái làm bong tim bị đẩy sang bên phải).

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

+ Nghe: Rì rào phế nang giảm hoặc mất. Có thể nghe tiếng cọ màng phổi phía trên vùng có dịch. Nếu nghe rale nổ, ẩm là có tổn thương vùng nhu mô do phối hợp với lao phổi.

6. Một số thể lâm sàng ít gặp:

6.1. Lao màng phổi tràn dịch khu trú:

- Khu trú vùng rãnh liên thùy.
- Khu trú vùng nách.
- Khu trú trung thất.
- Khu trú trên cơ hoành.

6.2. Lao màng phổi thể khô: Nghe thấy tiếng cọ màng phổi.

6.3. Tràn dịch kết hợp tràn khí màng phổi do lao:

Thăm khám thấy tràn dịch ở phía dưới và hội chứng tràn khí ở phía trên (rung thanh mất, rì rào phế nang mất, gõ vang ở phía trên).

6.4. Lao phổi kết hợp:

Ngoài những dấu hiệu tràn dịch màng phổi còn thấy những biểu hiện của tổn thương nhu mô như rale ẩm, rale nổ, tiếng thổi hang, ho khạc đàm hoặc ho ra máu.

6.5. Lao đa màng:

- Tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng bụng do lao.
- Tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim do lao.
- Tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng bụng, tràn dịch màng tim do lao.
- Tràn dịch màng phổi hai bên do lao.

7. Cận lâm sàng:

7.1. Chụp X-quang phổi:

- Tràn dịch màng phổi lượng ít: Đám mờ đều vùng đáy phổi, làm mất góc sườn hoành (số lượng dịch khoảng 0,5 lít).

- Tràn dịch trung bình: Đám mờ đậm, đều chiếm một nữa hoặc 2/3 trường phổi. Lượng dịch khoảng 1 – 2 lít, trung thất bị đẩy sang bên đối diện. Có thể thấy giới hạn trên của vùng mờ là một đường cong mặt lõm hướng lên trên (gọi là đường cong damoiseau).

- Tràn dịch nhiều: Mờ đều, đậm toàn bộ trường phổi, trung thất bị đẩy sang bên đối diện, khe gian sườn giãn rộng, cơ hoành bị đẩy xuống thấp (Khoảng 3 lít).

- Tràn dịch khu trú: Tùy theo vị trí tràn dịch có những vùng mờ tương ứng.

+ Tràn dịch rãnh liên thùy: Đám mờ đều hình thoi nằm tương ứng rãnh liên thùy.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

+ Tràn dịch màng phổi vùng nách: Trên phim X-quang phổi thẳng thấy đám mờ đều, giới hạn rõ nằm tiếp giáp ở lồng ngực phía ngoài.

+ Tràn dịch vùng trung thất: Bóng trung thất rộng ra không đối xứng.

- Tràn dịch kết hợp với tràn khí màng phổi: Phía dưới là là vùng tràn dịch mờ đậm đều, phía trên là vùng tràn khí quá sáng thuần nhất, ranh giới giữa 2 vùng là một đường nằm ngang.

7.2.Xét nghiệm dịch màng phổi:

Sau khi xác định chính xác có tràn dịch màng phổi, chỉ định chọc hút dịch màng phổi. Vị trí chọc ở khoang gian sườn 8 hay 9 trên đường ra nách sau. Dịch trong lao màng phổi thường dịch màu vàng chanh dính có thể đông lại sau khi được hút ra khỏi khoang mành phổi (do có nhiều albumin). Dịch cũng có thể màu hồng hoặc đục.

- Sinh hóa:

+ Albumin: >30g/l dịch tiết.

+ Phản ứng Rivalta: Dương tính.

+ Fibrinogen: > 6g/l (Bình thường <1 g/l).

+ Men LDH (Lactate Dehydrogenase) dịch màng phổi tăng, bình thường ≤ 195 UI/lít.

$$\text{Tỷ lệ: } \frac{LDH(DMP)}{LDH(HT)} > 0{,}6$$

Trong đó: LDH(DMP): LDH dịch màng phổi

LDH(HT): LDH huyết thanh

+ Glucose trong dịch màng phổi thấp hơn glucose máu (Thường < 60 mg/dl).

+Amylase: Nếu do viêm tụy cao hơn amylase máu bình thường 86 – 268 UI/lít.

+ Khi PH của dịch < 7,3 hướng nghĩ đến lao.

- Tế bào: Trong lao điển hình bạch cầu lympho chiếm 80 – 90 % thành phần các tế bào. Có thể thấy một số hồng cầu, bạch cầu đa nhân, tế bào nội mô màng phổi.

- Vi khuẩn:

+ Soi trực tiếp khó tìm thấy AFB.

+ Soi thuần nhất dịch màng phổi tỷ lệ AFB(+) khoảng 5 -10%.

+ Nuôi cấy dịch màng phổi tìm vi khuẩn lao, theo các tác giả Việt Nam thì tỷ lệ dương tính khoảng 13%, theo các tác giả nước ngoài thì dương tính khoảng 25%.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

7.3 Sinh thiết màng phổi (Qua soi màng phổi hoặc sinh thiết mù: Xét nghiệm giải phẫu tìm tổn thương lao đặc hiệu (nang lao, viêm xơ).Đây là thủ thuật không gây tai biến cho kết quả sinh thiết dương tính, giúp chẩn đoán xác định nguyên nhân do lao gây tràn dịch.

7.4. Phản ứng Mantoux: Dương tính mạnh.

7.5. Siêu âm màng phổi:

Giúp xác định nhanh chóng tràn dịch màng phổi, xác định vị trí tràn dịch, mức độ tràn dịch. Qua siêu âm đánh dấu vị trí để chọc hút dịch trên thành ngực bệnh nhân.

7.6. Xét nghiệm máu:

Số lượng bạch cầu bình thường hoặc tăng ít, tỷ lệ bạch cầu lympho cao, tốc độ lắng máu tăng.

7.7. Các xét nghiệm khác:

- Tìm AFB trong đàm dương tính. Nếu có lao phổi phối hợp, cần tìm AFB trong đàm với tất cả các trường hợp tràn dịch màng phổi do lao.

- Phản ứng Elisa dịch màng phổi, chụp cắt lớp phổi, màng phổi...

8. Chẩn đoán:

8.1. Chẩn đoán tràn dịch màng phổi:

- Lâm sàng:

+ Hội chứng tràn dịch màng phổi: Lồng ngực vồng, gõ đục, rung thanh giảm, rì rào phế nang giảm hoặc mất.

+ Cần phân biệt với dày dính màng phổi, xẹp phổi, xơ phổi.Các trường hợp này đều có hội chứng 3 giảm nhưng lồng ngực bên bệnh không vồng lên mà co kéo (long ngực lép) so với bên đối diện.

- Cận lâm sàng: Chiếu chụp X-quang phổi, siêu âm màng phổi thấy hình ảnh tràn dịch.

8.2. Chẩn đoán nguyên nhân:

- Chọc màng phổi lấy dịch vàng chanh xét nghiệm sinh hóa: Albumin > 30 g/l, tế bào lympho chiếm 80 – 90 %, vi khuẩn khó tìm nên cần dựa vào phản ứng mantoux dương tính mạnh, có nguồn lây lao, tuổi trẻ từ 16 – 30 tuổi, VS tăng, X-quang có lao phổi phối hợp.

- Sinh thiết màng phổi tìm thấy tổn thương đặc hiệu của lao là dấu hiệu quan trọng trong chẩn đoán. Nếu tìm thấy tổn thương lao ở bộ phận khác của cơ thể (Tìm AFB(+) trong đàm) là yếu tố góp phần chẩn đoán.

- Trong điều kiện một bác sĩ bác sĩ tuyến huyện, muốn chẩn đoán lao màng phổi cần dựa vào các yếu tố:

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

+ Có biểu hiện lâm sàng của tràn dịch màng phổi: Đau ngực, khó thở, triệu chứng nhiễm lao kèm khám lâm sàng lồng ngực vồng, gõ đục, rung thanh giảm, rì rào phế nang giảm hoặc mất.

+ X-quang: Mờ đồng nhất đáy phổi, góc sườn hoành mất giới hạn trên đường cong damoiseau.

+ Siêu âm: Xác định tràn dịch, vị trí tràn dịch.

+ Chọc dịch xét nghiệm dựa sinh hóa tế bào.

+ Dựa dấu hiệu khác: Tuổi trẻ, có nguồn lây lao, VS tăng, Mantoux dương tính mạnh, X-quang có lao phổi phôi hợp, xét nghiệm đàm AFB(+).

8.3. Chẩn đoán phân biệt:

- Tràn dịch màng phổi do ung thư nguyên phát hoặc do di căn, tuổi trên 30. Do nguyên phát dịch vàng chanh chuyển dần sang màu đỏ (4 tuần), do di căn dịch đỏ 90%. Dịch tái lập nhanh (1 – 2 ngày đầy lại như cũ). Tìm thấy tế bào lạ trong dịch màng phổi hoặc qua sinh thiết màng phổi. Men LDH tăng cao trên 500UI/lít. Tìm dấu hiệu ung thư nguyên phát, ung thư dạ dày, tử cung...

- Tràn dịch màng phổi do virus: Dịch trong, số lượng ít, hấp thu nhanh, chẩn đoán xác định bằng phân lập virus. Diễn biến bệnh tự hết sau 1 tuần.

- Tràn dịch màng phổi do một số nguyên nhân khác:

+ Suy tim, xơ gan, suy thận đều là dịch thấm, dịch thường có cả hai bên, số lượng ít, đi kèm bệnh phối hợp.

+ Tràn dịch màng phổi có E% cao 10% gặp trong hội chứng Loeffer, viêm phổi...

+ Viêm tụy: Có amylase tăng trong máu, dịch màng phổi.

+ Bệnh lupus ban đỏ, bệnh colagenases, viêm khớp dạng thấp, xét nghiệm C_3, C_4 của bổ thể thấp.

+ Hội chứng Demons Meigs: U nang buồng trứng phối hợp tràn dịch màng phổi tự do. Cắt bỏ u nang thì tràn dịch màng phổi hết.

9. Diễn biến:

9.1. Tốt: Hết sốt sau 1 tuần, hết dịch sau 3 – 4 tuần lễ không để lại di chứng dày dính, nếu gặp ở những bệnh nhân trẻ tuổi, lao màng phổi đơn thuần, phát hiện sớm, điều trị kịp thời.

9.2. Xấu: Những bệnh nhân lớn tuổi, suy kiệt, suy giảm miễn dịch, lao màng phổi phối hợp lao phổi thường có những diễn biến xấu:

- Dày dính màng phổi.
- Tràn dịch màng phổi kết hợp với tràn khí màng phổi.
- Tràn dịch màng phổi bội nhiễm.
- Ổ cặn màng phổi.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Dò khoang màng phổi ra thành ngực.
- Lao đa màng.

10. Điều trị:

10.1. Điều trị nguyên nhân:

- Người lớn dùng phác đồ **A1: 2RHZE/4RHE.**
- Trẻ em dùng phác đồ **A2: 2RHZE/4RH.**

(Giải thích sơ)

10.2. Chọc hút dịch mang phổi: Là thủ thuật có giá trị điều trị quan trọng và quyết định kết quả điều trị. Cần chọc hút dịch sớm, mỗi tuần rút 2 – 3 lần, mỗi lần khoảng 1.000ml, hút cho tới khi hết dịch (có khoảng 80% bệnh nhân phải chọc dịch hút 3 lần).

Dò phế quản –màng phổi: Đặt ống dẫn lưu màng phổi cùng với hóa trị liệu lao. Tiến hành bóc vỏ màng phổi nếu dò vẫn không hết sau điều trị.

10.3. Chống dày dính màng phổi:

Liệu pháp corticoid có tác dụng chống viêm, giảm tiết dịch và chống dày dính. Nhưng corticoid có khuyết điểm kèm suy giảm miễn dịch nên ngày nay chỉ sử dụng corticoid trong các trường hợp lao màng phổi kèm lao màng bụng, lao màng ngoài tim (Lebeau, 1989). Cách dùng là dùng ngay từ đầu, thời gian dùng 6 – 8 tuần, liều lượng: 0,6 – 0,8 mg/kg/ngày., giảm liều trước khi ngưng diều trị.

10.4. Vật lí liệu pháp:

Bệnh nhân cần được hướng dẫn tập thở sớm ngay khi hết sốt, nhưng vẫn còn dịch màng phổi, phải tập hàng ngày:

- Thời gian: Tập kéo dài khoảng 3 tháng.
- Mục đích: Phục hồi chức năng hô hấp và giúp màng phổi không bị dày dính.
- Cách tập: Thở bụng, thở bong bong, vận động hô hấp.

10.5. Điều trị kết hợp ngoại khoa:

Khi có biến chứng ổ cặn màng phổi, dày dính màng phổi nhiều (Trên phim X-quang có hình ảnh mai mực ở thành ngoài lồng ngực) dò màng phổi thành ngực, dò màng phổi, phế quản gây ho khạc mủ.

11. Phòng bệnh:

- Tiêm phòng BCG trẻ em.
- Phát hiện sớm, điều trị sớm lao sơ nhiễm, lao phổi.
- Phát hiện sớm, điều trị triệt để nguồn lây lao có AFB(+).
- Nâng cao sức đề kháng có thể: Làm việc điều độ, chế độ ăn uống dinh dưỡng tốt.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Bệnh học lao phổi, Phạm Long Trung, NXB Đà Nẵng năm 2000.
2. Bệnh học lao, NXB y học năm 2002.
3. Bệnh học lao, GS.Trần Văn Sang, NXB y học, Hà Nội năm 2007.
4. Giáo trình bệnh học lao và bệnh phổi, Bộ Môn Lao và Bệnh Phổi, Đại Học Y Dược TP.HCM, năm 2015.

ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO

A. HÀNH CHÍNH

1. Tên môn học: Bệnh lao
2. Tên tài liệu học tập: Điều trị bệnh lao.
3. Bài giảng: Lý thuyết
4. Số tiết: 3 tiết
5. Đối tượng sinh viên: Y5 hệ 6 năm
6. Địa điểm giảng: Giảng đường

B. MỤC TIÊU

1. Trình bày được cơ sở dược lý và vi khuẩn học trong điều trị bệnh lao.
2. Trình bày được tác dụng, tác dụng phụ, liều lượng, hàm lượng và cách dùng của 5 loại thuốc kháng lao thiết yếu.
3. Nêu được 4 nguyên tắc cơ bản trong điều trị bệnh lao.
4. Trình bày được 3 phác đồ điều trị bệnh lao của CTCLQG hiện nay.

C. NỘI DUNG

1. Mở đầu:

Bệnh lao là một bệnh nhiễm khuẩn và lây cho nên việc điều trị là nhằm mục đích diệt vi khuẩn để tránh lây lan. Tuy nhiên cơ thể là một khối thống nhất, do đó để nâng cao hiệu quả điều trị chúng ta cần dùng thuốc (hóa trị liệu) kết hợp dinh dưỡng nâng cao thể trạng, điều trị triệu chứng và phục hồi chức năng.

Ngày nay nhờ có thuốc đặc trị, bệnh lao có thể được điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên kết quả điều trị tốt hay xấu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chẩn đoán sớm hay muộn, phác đồ điều trị, thuốc men, sự hiểu biết và ý thức chấp hành của bệnh nhân cũng như sự kiểm soát quản lý thuốc của chương trình, điều kiện kinh tế xã hội...

Thuốc kháng lao chỉ có thể diệt được trực khuẩn lao, hạn chế tử vong, tránh lây lan cho cộng đồng chứ không xóa hoàn toàn được tổn thương do chúng gây ra(như tổn thương xơ, hang, vôi hóa...). Phát hiện sớm và điều trị kịp

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

thời giúp hạn chế được những biến chứng và di chứng, nâng cao chất lượng khỏi bệnh, sớm trả bệnh nhân về với lao động, sản xuất bình thường.

Hiện nay, biện pháp điều trị lao chủ yếu là nội khoa, chỉ định điều trị ngoại khoa kết hợp chỉ còn được áp dụng ở một số ít các trường hợp, nhằm giải quyết một số di chứng hoặc biến chứng (như ổ cặn màng phổi, nạo vét ổ áp xe, bóc vỏ màng phổi...) Hình thức điều trị chủ yếu là ngoại trú, kể cả trường hợp AFB(+) có điều kiện kinh tế và cần thiết cách ly trong 1 hoặc 2 tháng đầu.

2. Một số cơ sở khoa học trong điều trị bệnh lao:

2.1. Cơ sở vi khuẩn học:

2.1.1. Số lượng vi khuẩn và sự đột biến kháng thuốc:

Một quần thể vi khuẩn càng lớn thì khả năng có số lượng vi khuẩn đột biến kháng thuốc càng cao. Người ta đã chứng minh được hiện tượng đột biến kháng thuốc của vi khuẩn lao bằng một số thí nghiệm sau: Một TK lao nhạy cảm với INH (ở nồng độ 0,05µg/ml) được nuôi cấy (ở môi trường không có INH) cho phát triển đến 1000 con, lúc này nếu cho tiếp xúc với thuốc INH nồng độ 0,05µg/ml ta thấy toàn bộ TK lao đều bị tiêu diệt (chưa thấy có hiện tượng BK kháng thuốc). Nhưng nếu tiếp tục để cho phát triển đến 1.000.000 con, rồi mới cho tiếp xúc với INH nồng độ trên, ta thấy vẫn còn một số TK lao còn tồn tại và phát triển, sở dĩ có trường hợp như vậy là do TK lao đã có đột biến kháng thuốc. Đây là diễn tự nhiên trong quá trình phát triển của vi khuẩn. Trong quá trình phát triển dưới tác động của một số yếu tố (vật lý hay hóa học) nào đó sẽ làm cho vi khuẩn phát triển khác thường (gọi là đột biến) trở thành VK kháng thuốc, ta gọi đó là hiện tượng đột biến kháng. Hiện tượng đột biến kháng thuốc khác nhau tùy theo từng loại thuốc kháng sinh. Người ta thấy tỉ lệ đột biến kháng thuốc của Rifampicine (RMP) là $1/10^7$, của Streptomycine(SM) là $1/10^6$ của Isoniazide (INH) và Ethambutol (EMB) là $1/10^5$. Vì vậy chúng ta cần lưu ý đến số lượng BK hiện diện trong các loại tổn thương: Một hang lao đường kính 2 cm thông với phế quản (chưa được điều trị) có khoảng từ 10^8 đến 10^{12} TK lao, một ổ bã đậu có đường kính 2cm có khoảng 10^5 TK lao, trong khi một nốt lao có cung kích thước chỉ có khoảng $10^2 – 10^4$ TK lao. Như vậy một tổn thương hang lao trước khi được điều trị đặc hiệu đã có ít nhất 10 TK lao kháng RMP, 100 TK lao kháng SM, 1000 TK lao kháng INH và EMB. Vì vậy nếu chỉ điều trị lao bằng một loại thuốc đặc hiệu thì sẽ dễ dàng chọn lọc dòng TK lao kháng lại thuốc đó. Từ 1 vài BK kháng thuốc sẽ sinh sản phát triển thành một quần thể lớn TK lao kháng thuốc. Chúng ta biết rằng, từ 1 TK lao sau 10 ngày với 12 tơi 14 lần nhân đôi) sẽ phát triển tới 5000 TK lao và sau 1 tháng số lượng TK lao sẽ

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

là 100 triệu TK lao. Vì vậy sẽ là một sai lầm lớn nếu bắt đầu điều trị lao với lần lượt từng loại thuốc kháng lao.

Một số khái niệm về kháng thuốc:

- Kháng thuốc tự nhiên: Một chủng TK lao dòng dại đã có khả năng đề kháng một cách tự nhiên với một vài loại kháng sinh nào đó.

- Kháng thuốc tiên phát (primary resistance): Kháng thuốc xảy ra ở TK lao chắc chắn chưa bao giờ dùng thuốc lao trước đó (Nhưng có thể BN đã nhiễmloại TK lao kháng thuốc từ một BN lao khác có quá trình điều trị không đúng). Kháng thuốc tiên phát chiếm khoảng 5 – 10 % ở các nước phát triển, 10 – 15% ở các nước đang phát triển (K.Toman 1985).

- Kháng thuốc mắc phải (thứ phát – Acquired resistance): Kháng thuốc xảy ra trong quá trình điều trị, do BN đã được điều trị lao không đúng (như không đủ thời gian, hoặc không đủ liều lượng...) làm cho vi khuẩn có đủ thời gian gây đột biến kháng thuốc. Tỷ lệ kháng thuốc mắc phải trung bình chiếm 36% (WHO 1997).

- Kháng thuốc ban đầu (Combined resistance): Kháng thuốc xảy ra ở bệnh nhân khai chưa dùng thuốc kháng lao bao giờ (nhưng không chắc chắn, có thể bệnh nhân dấu không chịu khai báo), kháng thuốc ban đầu bao gồm kháng thuốc tiên phát, kháng thuốc mắc phải và kháng thuốc tự nhiên.

- Đa kháng thuốc: Là kháng một lúc với ít nhất 2 loại thuốc (trong đó có RMP và INH).

2.1.2. Sự chuyển hóa của trực khuẩn lao:

Sự sinh sản và phát triển của TK lao tùy thuộc vào môi trường, vị trí và đặc điểm của tổn thương như PH môi trường, phân áp oxy, ở tổn thương hang hay ở tổ chức bã đậu... Theo D.A.Mitchison và J.M.Dickinson tại hội nghị chống lao quốc tế Bruxel(Bỉ) năm 1987 đã chia quần thể TK lao thành 4 nhóm sau:

- Nhóm A: Gồm những TK lao đang phát triển nhanh (nằm ngoài tế bào, khu trú ở vách các hang lao,có đủ phân áp oxy, nồng độ pH kiềm). Nhóm này dễ bị tiêu diệt bởi các thuốc đặc trị như SM, RMP,INH,EMB.

- Nhóm B: Có số lượng ít hơn nhóm A, gồm những BK nằm ngoài tế bào, trong các tổ chức bã đậu, hoặc ở sâu trong vách hang lao, có pO_2 thấp nên TK lao sinh sản chậm (chỉ chuyển hóa từng đợt ngắn), EMB,RMP có tác dụng tốt, INH ít tác dụng và SM tác dụng hạn chế.

- Nhóm C: Gồm những TK lao đã bị đại thực bào thôn tính, TK lao nằm trong tế bào (nội bào) có pH toan, pO_2 thấp nên TK lao phát triển chậm. Thuốc

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

PZA có tác dụng diệt khuẩn mạnh, RMP có tác dụng một phần, INH ít tác dụng còn SM không tác dụng.

- Nhóm D: Gồm những TK lao nằm trong tế bào, hoàn toàn không chuyển hóa và phát triển, gọi là TK lao ngủ. Nhóm này ít hoặc không chịu tác dụng với các loại thuốc kháng lao. Điều may mắn là số lượng nhóm ít và có thể bị tiêu diệt bởi những hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Sở dĩ bệnh lao dễ tái phát là do đặc điểm của nhóm B,C,D. Vì vậy muốn điều trị đạt hiệu quả tốt, tránh tái phát ta phải phối hợp thuốc và kéo dài thời gian gian điều trị đủ để đảm diệt hết những TK lao thuộc các nhóm trên.

2.1.3. Cơ chế tác dụng của các thuốc kháng lao:

Các thuốc kháng lao tác dụng vào nhiều quá trình sinh học khác nhau của BK, làm rối loạn chuyển hóa của BK. Cũng có thuốc cho đến nay vẫn chưa hiểu rõ được cơ chế tác dụng. Ngày nay người ta mới biết được một số cơ chế tác dụng của một số thuốc kháng lao sau:

- RMP có tác dụng ức chế sự tổng hợp các acid nucleic của TK lao bằng cách hình thành một chất phức hợp với ARN-polymeraza, làm cho emzym này không còn khả năng khởi động sự tổng hợp các ARN mới.

- SM, Kanamycine(Viomycine, Capreomycine) ức chế sự tổng hợp protein của BK bằng cách gắn vào Ribosom 30S và 70S của TK lao.

- INH và Ethionamide có tác dụng ức chế sự tổng hợp polysaccarit của màng tế bào VK, làm mất tính kháng toan và phá hủy màng tế bào của TK lao.

- EMB có tác dụng kiềm khuẩn.

2.2. Cơ sở dược lý:

2.2.1. Liều lượng và nồng độ thuốc:

Tác dụng của thuốc đối với vi khuẩn tùy thuộc vào từng loại thuốc trong huyết thanh và nồng độ thuốc tại tổ chức tổn thương. Nồng độ này liên quan chặt chẽ với liều lượng và cách dùng thuốc.

2.2.1.1. Nồng độ đỉnh trong huyết thanh (CSM): Là nồng độ thuốc trong huyết thanh đạt cao nhất tại một thời điểm nhất định. Nồng độ này phụ thuộc sự chuyển hóa, hấp thu, liều lượng và cách dùng của từng loại thuốc. Nồng độ này thường đạt được sau 3 giờ dùng thuốc. Để đạt được nồng độ đỉnh trong huyết thanh cao nhất nên uống (hoặc tiêm) các thuốc kháng lao cùng một lúc vào lúc đói, để hạn chế thuốc gắn với protein trong máu, vì thuốc thường chỉ tác dụng với BK ở dạng tự do.

2.2.1.2. Nồng độ ức chế tối thiểu (CIM: Concentration minimum inhibitive): Là nồng độ thuốc thấp nhất trong huyết thanh mà vẫn còn khả năng

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

ức chế được sự phát triển của vi khuẩn. Liên hệ giữa nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ đỉnh huyết thanh ta có hệ số vượt:

Hệ số vượt = CSM/CIM

CSM (Concentration serum maximum): Nồng độ đỉnh huyết thanh.

CIM (Concentration minimum inhibitive): Nồng độ ức chế tối thiểu

Hệ số an toàn = liều độc/liều điều trị

Một thuốc kháng lao có hiệu quả tốt phải có hệ số vượt và hệ số an toàn cao. Thuốc lao muốn đạt được tác dụng diệt khuẩn thì hệ số vượt phải đạt ít nhất là 20 trong môi trường lỏng.

2.2.1.3. Nồng độ thuốc tại chỗ tổn thương: tỉ số giữa nồng độ thuốc tại tổ chức tổn thương với nồng độ thuốc trong huyết thanh tùy thuộc vào từng loại thuốc và tùy loại tổ chức khác nhau. Nồng độ này rất quan trọng vì là nơi thuốc tác động trực tiếp vào TK lao.

Người ta biết nồng độ của RMP và INH trong các tổn thương khác nhau so với nồng độ trong huyết thanh như sau (bảng 1):

Bảng 1: Tỷ số nồng độ thuốc RMP và INH tại tổ chức so với huyết thanh

Tỷ số	RMP	INH
Phổi/huyết thanh	1,6	0,6 – 0,8
Bã đậu/huyết thanh	0,35	0,3
Hang/huyết thanh	1,3	0,4 – 0,6

2.2.2. Thời gian tiềm tàng:

Là thời gian TK lao bất hoạt sau khi tiếp xúc với một nồng độ thuốc nào đó trong một thời gian nhất định.

Thời gian này dài hay ngắn tùy thuộc từng loại thuốc, nồng độ thuốc và thời gian tiếp xúc. Người ta đã biết được thời gian tiềm tàng của một số thuốc như sau (bảng 2, theo K.Thomas 1985):

Bảng 2: Thời gian tiềm tàng của BK sau khi tiếp xúc thuốc kháng lao

Loại thuốc	Nồng độ (mg/dl)	Thời gian tiềm tàng	
		6h tiếp xúc	24 h tiếp xúc
INH	1	0	6 - 9
Streptomycine	5	8 – 10	8 – 10
Ethambutol	10	0	4 – 5
Pyrazinamide	50	5 – 40 (*)	40 (*)
Rifampicine	0,2	2 – 3	2 – 3
Thiacetazone	10	0	0

(*) Tùy theo pH của môi trường (6,2 – 6,5)

Căn cứ vào thời gian tiềm tàng người ta đề xuất thuốc nào có thể dùng trong thời gian điều trị duy trì (khoảng cách). Thuốc Thiacetazone không có thời gian tiềm tàng, vì vậy không dùng để điều trị duy trì.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

2.3. Vấn đề cơ địa:

Trước khi có thuốc kháng lao, các yếu tố cơ địa như tình trạng dinh dưỡng , tuổi tác, bệnh tật kèm theo... rất được quan tâm và coi trọng, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến việc khỏi bệnh, chất lượng khỏi bệnh tùy thuộc hoàn toàn vào khả năng tự đề kháng của cơ thể.

Ngày nay, nhờ có thuốc kháng lao đặc hiệu, vai trò của yếu tố cơ địa và điều kiện thuận lợi không còn đóng vai trò quan trọng chủ yếu. Tuy nhiên chúng ta cũng cần lưu ý cơ thể là một khối thống nhất, vì vậy cũng không thể xem thường các yếu tố thuận lợi như cơ địa đái đường, suy dinh dưỡng, đặc biệt là nhiễm HIV/AIDS cũng làm cho việc điều trị trở nên khó khăn và hạn chế kết quả điêu trị.

Trên thực tế chúng ta cần lưu ý đến các yếu tố cơ địa như đái đường, xơ gan, suy gan, nghiện rượu, suy thận, cơ địa dị ứng thuốc... để có thể kết hợp biện pháp điều trị và điều chỉnh liều lượng thích hợp cũng như để theo dõi và tiên lượng các tác dụng phụ của thuốc có thể xảy ra đối với từng đối tượng.

3. Các thuốc kháng lao thiết yếu:

Bảng 3: Liều tối ưu của các thuốc kháng lao thiết yếu (Theo WHO 1997)

Tên thuốc	Liều dùng (mg/kg/ngày)	Cách khoảng (mg/kg)	
		3 lần/tuần	2 lần/tuần
INH	5 (4 -6)	10 (8 – 12)	15 (13 – 17)
RMP	10 (8 – 12)	10 (8 – 12)	10 (8 – 12)
SM	15 (12 – 18)	15 (12 – 18)	15 (12 – 18)
EMB	15 (15 -20)	30 (25 – 35)	45 (40 – 50)
PZA	25 (20 – 30)	35 (30 – 40)	50 (40 – 60)

3.1. Streptomycine(SM, S):

SM là thuốc kháng sinh thuộc nhóm Aminosid. Thuốc được dùng dưới dạng Streptomycine sulphate, trình bày dạng lo thuốc tiêm bắp, hàm lượng 1g, hay 5g. Liều lượng và cách dùng xem **Bảng 3.**

Streptomycine được Waksman tìm ra năm 1944, được chế xuất từ nấm Streptomyces Griseus(Actionmyces Griseus).

Tác dụng diệt BK ngoại bào sinh sản nhanh (nhóm TK lao ở thành hang lao), ngoài ra còn có tác dụng đối với một số VK gram (-) hoặc gram (+) khác. Thuốc bị ảnh hưởng bởi pH của môi trường, có tác dụng tốt ở môi trường kiềm. Thuốc không thấm qua được các màng sinh học bình thường, tuy nhiên có thể khuếch tán tốt qua các màng sinh học bị viêm (như màng não, màng phổi... bị viêm), xâm nhập được cả vào tổ chức xơ kén. Cơ chế tác dụng của SM là làm

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

ức chế sự tổng hợp protein của TK lao bằng cách gắn vào các Ribosom 30S và 70S. Thuốc qua được hàng rào nhau thai nên có thể gây độc cho thai nhi, vì chống chỉ định dùng SM đối với phụ nữ mang thai. SM được thải trừ chủ yếu qua đường thận, vì vậy cần lưu ý giảm liều đối với người có suy thận. TK lao dòng dại có tỉ lệ đột biến kháng thuốc khoảng $1/10^6$.

Một số tác dụng phụ thường gặp:

- Gây tổn thương tiền đình biểu hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, lảo đảo, thậm chí điếc không hồi phục, nguy cơ này tăng cao ở bệnh nhân có chức năng thận kém.

- Thuốc có thể gây phản ứng nhẹ, nhất thời như tê rần ở môi, hoặc sốt quá mẫn với các biểu hiện ban đỏ ngứa, trường hợp nặng có thể biểu hiện phù quanh hố mắt, viêm giác mạc, phù Quink, đỏ da toàn thân, nôn, có trường hợp sốc phản vệ (ít gặp).

3.2. Iso-Nicotinique Hydrazide(INH,H), tên khác Rimifon,Rimicid...:

Trình bày ở dạng viên nén 50mg, 100mg, 150mg, 300mg, còn có dạng ống tiêm hàm lượng 500mg.

Liều lượng và cách dùng xem **Bảng 3.**

Là một hóa chất được tổng hợp từ năm 1912 nhưng đến năm 1952 mới biết đến tác dụng điều trị lao của thuốc. INH là một thuốc kháng lao mạnh, rẻ tiền, ít độc tính. Thuốc thâm nhập tốt vào các mô (tổ chức), không bị ảnh hưởng bởi pH của môi trường, có tác dụng cả nội bào và ngoại bào. Nồng độ tối đa trong máu đạt được sau 1 – 2 giờ uống thuốc, nồng độ trong dịch não tủy bằng 1/5 nồng độ trong huyết thanh.

Thuốc chủ yếu được chuyển hóa ở gan thành dạng Acetyl hóa (Acetyl Isonyazide) chiếm 30 -50%, không có tác dụng với BK. Phần thuốc không bị chuyển hóa mới có tác dụng với TK lao và gắn với protein máu.

Khả năng Acetyl hóa khác nhau tùy theo đặc tính di truyền chủng tộc: Người châu Á, châu Phi thường thuộc nhóm chuyển hóa nhanh, người châu Âu thường có chuyển hóa chậm. Một trong những sản phẩm chuyển hóa của INH là Acetyl Hydrazine nếu gắn với tế bào gan dễ gây hoại tử tế bào gan, đặc biệt khi phối hợp với RMP.

Thuốc được gải trừ chủ yếu qua thận, ở dạng nguyên dạng hoặc chuyển hóa. Tuy nhiên ở bệnh nhân suy thận vẫn có thể dùng liều thông thường, lưu ý giảm liều ở bệnh nhân xơ gan hoặc suy gan. TK lao dòng dại có tỉ lệ đột biến kháng thuốc khoảng $1/10^5$.

Một số tác dụng phụ hay gặp:

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Viêm gan, hoại tử tế bào gan, đặc biệt khi kết hợp với RMP, dễ gặp ở bệnh nhân nghiện rượu, xơ gan..., với biểu hiện vàng da vàng mắt, tăng SGOT và SGPT trong máu. Tăng SGOT và SGPT có thể xảy ra trong vài tháng đầu (nếu <3 lần bình thường) không có biểu hiện triệu chứng, vẫn có thể tiếp tục điều trị. Nếu SGOT, SGPT tăng > 3 lần bình thường cần phải ngừng điều trị để theo dõi nguy cơ tai biến thuốc.

- Viêm dây thần kinh ngoại biên với biểu hiện dị cảm, tê, đau, bỏng rát da hoặc teo cơ. Độc tính tăng theo tùy theo liều dùng INH, và thường gặp ở bệnh nhân ở bệnh nhân có khử hoạt tính Acetyl hóa chất.

- Ít gặp: Hội chứng Pellagra (viêm da, tiêu chảy, mất trí), do INH làm tăng thải trừ Vitamin B6, nên làm giảm vitamin B6 trong máu. Một số trường hợp gây rối loạn nội tiết (chứng vú to ở nam giới), rối loạn tâm thần, kinh giật.

Các tai biến này có thể phòng ngừa bằng cách uống vitamin B6 với liều 10 – 20 mg/ngày, nếu dùng liều cao >50 mg/ngày có thể làm mất tác dụng kháng lao của INH (K.Thomas 1985).

- Chống chỉ định khi có viêm gan, hoại tử tế bào gan, trạng thái tâm thần phân liệt, bệnh nhân nghiện rượu nặng. Người ta khuyên khi có vàng da niêm lúc đang điều trị phối hợp với RMP cần phải ngừng ngay INH (Chứ không phải là RMP), sau khi hết vàng da có thể điều trị lại với liều tăng dần và cần được theo dõi chặt chẽ về lâm sàng và chức năng gan.

3.3. Ethambuton (EMB,E), tên khác Dexambutol,Myambutol(Pháp),Sural (Hungary), Servambutol (Thụy Sĩ), Syntomen (Đức)...:

Dạng thuốc viên nén hàm lượng 200 mg hoặc 400 mg.

Liều lượng và cách dùng xem **Bảng 3.**

Thuốc được tổng hợp từ năm 1961, có tác dụng kiềm khuẩn, làm ngừng sự sinh sản và phát triển của TK lao,tỷlệ đột biến kháng thuốc khoảng $1/10^5$. EMB được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, chuyển hóa một phần ở gan, bài tiết qua thận phần lớn ở nguyên dạng. Thuốc khuyếch tán vào các mô và dịch của cơ thể. Ở tổ chức bã đậu thuốc có nồng độ cao gấp 8 – 10 lần trong máu. Nồng độ ức chế tối thiểu (CMI) là 1 µg/ml.

Tác dụng phụ: Thuốc có thể gây một số tai biến thường gặp như:

- Viêm thần kinh thị giác (thần kinh số 2) làm giảm thị lực, mờ ám điểm và gây mù màu đỏ và màu xanh lục, do đó người ta khuyên không nên dùng EMB cho trẻ em vì không kiểm soát được thị lực của chúng. Độc tính ít gặp (nếu dùng đúng liều lượng) và có thể hết sau khi ngừng thuốc. Dù sao cũng cần theo dõi thị lực trong quá trình điều trị.

3.4. Pyrazinamid (Viết tắt: PZA,Z), tên khác: Prazina,Prazide,Pyzna..:

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

Thuốc dạng viên nén, hàm lượng 500mg.

Liều lượng và cách dùng xem **Bảng 3.**

Thuốc được tổng hợp vào năm 1950 và được sử dụng điều trị lao vào năm 1952. Tác dụng của thuốc bị ảnh hưởng bởi pH của môi trường, thuốc có tác dụng tốt trong môi trường toan và nội bào (TK lao trong các đại thực bào, sinh sản chậm). Thuốc được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, xâm nhập tốt vào các mô, nồng độ PZA trong dịch não tủy bằng nồng độ thuốc trong huyết thanh, vì vậy thuốc được ưu tiên sử dụng điều trị lao màng não (Theo Forgan Smith và CS). Thuốc được chuyển hóa chủ yếu ở gan (Thủy phân thành acid Pyrazynoic) , chất chuyển hóa vẫn có tác dụng lên trực khuẩn lao. Thuốc được thải trừ chủ yếu qua thận.

Một số tác dụng phụ của thuốc:

- Gây độc tính ở gan như viêm gan.

- Đau khớp, có khi gây triệu chứng gout do chất chuyển hóa acid pyrazynoic làm ngăn cản sự thải trừ acid uric ở thận, do đó làm tăng acid uric máu. Triệu chứng đau khớp có thể tự khỏi trong vòng 8 tuần đầu điều trị, có thể dùng aspirin liều 800-1000 mg/ngày để làm giảm triệu chứng này, ít khi phải ngừng thuốc.

- Một số phản ứng quá mẫn như sốt, mẫn ngứa ít gặp, dễ gây sạm da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đặc biệt ở vùng da hở không được áo quàn che phủ.

- Rối loạn tiêu hóa như chán ăn, buồn nôn hoặc nôn.

3.5. Rifampicine (Viết tắt: RMP,R), tên khác Rimactan, Rifadin, Tubocine...:

Thuốc được trình bày dưới dạng viên nén có vỏ bọc hoặc viên nang, hàm lượng 150 mg hoặc 300 mg. Có dạng viên phối hợp Rifampicine với Isoniazide (có tên là Rimactazide hay viên RH), có 2 loại viên: 300 mg Rifampicine + 150 mg INH và lọa viên 150 mg Rifampicine + 100 mg INH.

Liều lượng và cách dùng xem **Bảng 3.**

Thuốc Rifampicine là loại thuốc bán tổng hợp từ Rifampicine sinh vật, được phát hiện năm 1965. Rifampicine SV được phân lập từ nấm Streptomycys mediteranei.

Rifampicine là một thuốc kháng lao mạnh, không bị ảnh hưởng bởi pH của môi trường, có tác dụng nội bào và ngoại bào. Ngoài ra thuốc còn có tác dụng đối với VK Gram (-), Gram (+) và cả với một số trực khuẩn lao không điển hình (Mycobacterium Atypique). Thuốc có nồng độ ức chế tối thiểu thấp

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

(0,15 µg/ml), hệ số vượt cao từ 60 – 100, có tỷ lệ đột biến kháng thuốc thấp ($1/10^7$).

Thuốc được hấp thu tốt ở ruột non, chuyển hóa ở gan thành Desacetyl – rifampicine nhưng vẫn còn tác dụng với TK lao. Phần thuốc không được chuyển hóa bài tiết qua ruột và được tái hấp thu trở lại (ta gọi đó là chu kỳ ruột – gan), nên có nồng độ cao trong máu (nồng độ giờ thứ 3 và giờ thứ 6 bằng nhau dù dùng riêng hay dùng chung với các thuốc chống lao khác).

Thuốc được bài tiết một phần qua nước tiểu (Khoảng 20%) nên nước tiểu thường có màu đỏ. Thuốc cũng qua được nhau thai, qua sữa, nước bọt, nước mắt. Lưu ý cần thận trọng giảm liều ở bệnh nhân có xơ gan, suy giảm chức năng gan.

Một số tác dụng phụ có thể gặp: Nếu thuốc được dùng riêng, ít độc cho gan, nhưng độc tính tăng lên khi dùng kết hợp với INH (đây lại là phác đồ phổ biến và tốt nhất hiện nay).

- Gây viêm gan vàng da do ứ mật, xảy ra trong mấy tuần đầu điều trị thường có chuyển biến tốt.

- Viêm gan nặng, hoại tử tế bào gan biểu hiện tăng các men Transaminase (SGOT,SGPT), đặc biệt khi dùng chung với INH, có trường hợp tử vong.

- Ngoài ra thuốc còn có thể gây dị ứng, ban xuất huyết, hội chứng cúm, choáng phản vệ, suy thận cấp, thiếu máu huyết tán, xuất huyết giảm tiểu cầu, rối loạn tiêu hóa với biểu hiện nôn hay buồn nôn.

- Người ta thấy độc tính của thuốc càng cao khi điều trị với thời gian cách khoảng càng xa, độc tính sẽ giảm nếu trước đó đã dùng giai đoạn tấn công hàng ngày.

- Thuốc lam giảm tác dụng của thuốc ngừa thai (Oestrogen) và thuốc hạ đường huyết (Insulin). Vì vậy phụ nữ đang uống thuốc ngừa thai, khi điều trị lao cần lưu ý thay đổi biện pháp tránh thai để không bị vỡ kế hoạch.

3.6. Một số thuốc kháng lao thứ yếu: Hiện nay ít dùng do độc tính cao và tác dụng kháng lao yếu.

- **Kanamycine, Viomycine, Capreomycine:** Tác dụng tương tự SM, độc tính cao hơn SM, có đề kháng chéo giữa 3 thứ thuốc. Liều dùng: 1g/ngày, tiêm bắp.

- **Cycloserin:** Là thuốc kháng lao yếu, có độc tính với thần kinh trung ương gây kích thích điên loạn. Liều dùng: 0,5 g – 1g/ngày, chia 2 lần (10 – 20 mg/kg/ngày).

- **Thiacetazone:** Viên nén 50 mg, 100mg, còn có dạng viên kết hợp với INH gọi là TB_1, loại viên nén 300 mg INH + 150 mg Thiacetazone hoặc viên

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

100 mg INH + 50 mg Thiacetazone. Liều dùng: 3mg/kg/ngày. Thuốc dung nạp tốt ở người châu Phi. Độc tính gây mẫn đỏ, ngứa, vàng da, suy tủy xương, gây rối loạn tiêu hóa, có khi gây hội chứng viêm da nặng như: Hội chứng Lyell, hội chứng Stevens – Iohnson. Việt Nam còn dùng viên này trước năm 1985, hiện nay không được dùng.

- **Ethionamide là thuốc gần giống Prothionamide(Trecator):** Thuốc có tác dụng kháng lao yếu. Dạng viên nén 250 mg, liều dùng: 10 – 15 mg/kg/ngày (Khoảng 500 – 750 mg/ngày), chia hai lần ở bệnh nhân có trọng lượng 50 kg.
Tác dụng phụ gây rối loạn tiêu hóa như chán ăn, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy...

- **Para-amino salicylic acid (PAS):** Thuốc có từ năm 1946, có tác dụng kháng lao yếu, thường dùng dưới dạng muối sodium. Thuốc có dạng viên nén 500 mg, hoặc bột, liều người lớn 10 – 12 g/ngày chia 2 hoặc 3 lần. Ngoài phản ứng quá mẫn như sốt, ngứa, mẫn đỏ, thuốc thường gây rối loạn tiêu hóa.

- **Fluoroquinolone:** Ofloxacine, Ciprofloaxacine.

- **Macrolide:** Azithromycine, Roxythromycine,Clarithromycine.

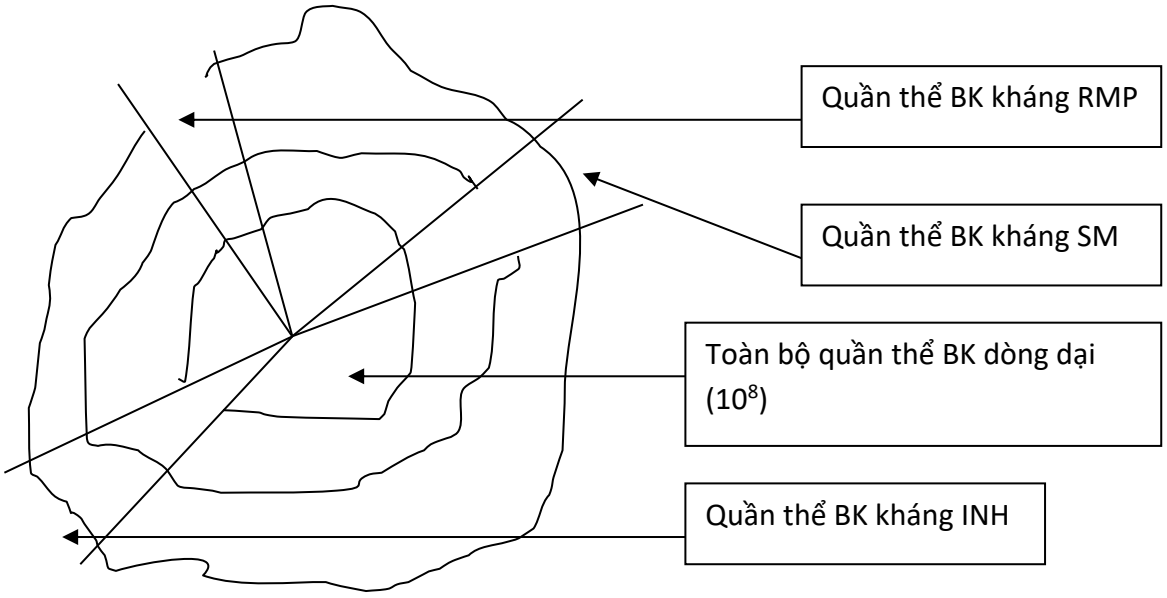
- **Nhóm Beta lactam:** Ampicilline, Amoxycilline + acid clavulanic.

4. Điều trị nội khoa bệnh lao:

4.1. Nguyên tắc:

4.1.1. Phối hợp thuốc:

Phối hợp ít nhất 3 loại thuốc kháng lao ngay từ giai đoạn đầu (giai đoạn tấn công) để cùng một lúc diệt một số lượng lớn TK lao nhằm mục đích hạn chế tối đa sự đột biến kháng thuốc, tránh hiện tượng chọn lọc dòng TK lao kháng thuốc **(hình 1)**



Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

4.1.2. Đúng liều lượng:

Liều lượng thuốc phải đủ để tiêu diệt được BK (xem bảng 3). Để đạt được nồng độ đỉnh huyết thanh cao trong máu cần uống và tiêm các thuốc kháng lao cùng một lúc vào buổi sáng (khi đói). Nếu liều thấp dễ tạo sự chọn lọc dòng TK lao kháng thuốc.

4.1.3. Đủ thời gian:

Thời gian ngắn nhất cho phép đối với điều trị lao là 6 tháng (Nếu có RMP), thông thường từ 8 – 9 tháng, đảm bảo đủ thời gian diệt được toàn bộ TK lao để tránh tái phát. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu điều trị thời gian càng ngắn (<6 tháng) tỷ lệ tái phát càng cao.

4.1.4. Liên tục và có kiểm soát: Điều trị liên lục với 2 giai đoạn:

- Giai đoạn tấn công: Dùng thuốc hàng ngày.
- Giai đoạn duy trì (hay cách khoảng): dùng thuốc hàng ngày, 2 lần hoặc 3 lần 1 tuần, tùy theo phác đồ điều trị theo liều qui định (bảng 3).

Đồng thời trong quá trình điều trị phải kiểm tra kết quả âm tính hóa đờm để đánh giá hiệu quả điều trị, kịp thời xử lí tai biến thuốc có thể gặp.

4.2. Một số phác đồ điều trị lao (của chương trình chống lao quốc gia hiện nay từ 1/6/2018):

Hiện nay để tăng cường hiệu quả công tác chống lao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại đối với BN lao, chương trình Chống lao đã cung cấp thuốc kháng lao về tận các tuyến y tế địa phương (xã, phường), bảo đảm BN được uống (tiêm thuốc) tại trạm y tế dưới sự kiểm soát của nhân viên y tế, gọi là "DOTS": "hóa trị liệu ngắn hạn có kiểm soát trực tiếp" (DOTS: Directly Observed Treatment Short Course): Giai đoạn tấn công 2 tới 3 tháng với ít nhất 4 loại thuốc kháng lao (SHRZ), giai đoạn duy trì 4 tới 10 tháng (tùy theo phác đồ) với ít nhất 2 loại thuốc kháng lao.

Bảng 3: Liều tối ưu của các thuốc kháng lao thiết yếu (Theo WHO 1997)

Tên thuốc	Liều dùng (mg/kg/ngày)	Cách khoảng (mg/kg)	
		3 lần/tuần	2 lần/tuần
INH	5 (4 -6)	10 (8 – 12)	15 (13 – 17)
RMP	10 (8 – 12)	10 (8 – 12)	10 (8 – 12)
SM	15 (12 – 18)	15 (12 – 18)	15 (12 – 18)
EMB	15 (15 -20)	30 (25 – 35)	45 (40 – 50)
PZA	25 (20 – 30)	35 (30 – 40)	50 (40 – 60)

4.2.1. Phác đồ A1: **2RHZE/4RHE**

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- *Chỉ định:* Dùng cho tất cả mọi thể lao ở người lớn không có bằng chứng kháng thuốc.

- *Cách dùng:* Giai đoạn tấn công kéo dài 2 tháng, dùng 4 loại thuốc Rifampicin, Rimifon, Pyrazinamide và Ethambutol *hàng ngày*. Giai đoạn duy trì kéo dài 4 tháng, dùng 3 thuốc Rifampicin, Rimifon và Ethambutol *hàng ngày*.

- *Liều lượng:* (xem bảng 3).

***4.2.2. Phác đồ A2:* 2RHZE/4RH**

- *Chỉ định:* Dùng trong tất cả các trường hợp bệnh lao ở trẻ em, không có bằng chứng kháng thuốc.

- *Cách dùng:* Giai đoạn tấn công kéo dài 2 tháng, dùng 4 loại thuốc Rifampicine, Rimifon, Pyrazinamide và Ethambutol *hàng ngày*. Giai đoạn duy trì kéo dài 4 tháng, dùng 2 loại thuốc Rimifon, Rifampicine *hàng ngày*.

- *Liều lượng:* (xem bảng 3).

4.2.3. Phác đồ B1: 2RHZE/10RHE

- *Chỉ định:* lao màng não, lao xương khớp và lao hạch ở người lớn.

- *Cách dùng:* Giai đoạn tấn công kéo dài 2 tháng, dùng 4 loại thuốc Rifampicine, Rimifon, Pyrazinamide và Ethambutol *hàng ngày*. Giai đoạn duy trì kéo dài 10 tháng, dùng 3 loại thuốc Rimifon, Rifampicine và Ethambutol *hàng ngày*.

4.2.4. Phác đồ B2: 2RHZE/10RH

- *Chỉ định:* lao màng não, lao xương khớp và lao hạch ở trẻ em.

- *Cách dùng:* Giai đoạn tấn công kéo dài 2 tháng, dùng 4 loại thuốc Rifampicine, Rimifon, Pyrazinamide và Ethambutol *hàng ngày*. Giai đoạn duy trì kéo dài 10 tháng, dùng 2 loại thuốc Rimifon, Rifampicine *hàng ngày*.

Theo dõi điều trị: Trong quá trình điều trị, bệnh nhân cần được kiểm soát dùng thuốc, đánh giá đáp ứng lâm sàng, X quang, tác dụng phụ của thuốc và cần được xét nghiệm đờm theo dõi:

* Đối với thể lao phổi AFB(+) phải xét nghiệm 3 lần:

Phác đồ 6 tháng: XN đờm vào cuối tháng thứ 2, 5 và 6;

* Đối với thể lao phổi AFB (-): XN đờm 2 lần vào cuối tháng thứ 2 và thứ 5

4.3. Corticoid trong điều trị bệnh lao:

Vai trò của corticoid trong điều trị bệnh lao vẫn còn nhiều ý kiến bàn cãi. Corticoid được dùng trong một số trường hợp lao, đặc biệt là các thể lao màng như lao màng phổi, lao màng não, lao màng bụng... Thuốc có tác dụng làm giảm viêm, hạn chế di chứng dày dính. **Tuy nhiên cần lưu ý chỉ dùng corticoid trong những trường hợp lao mới và đồng thời phải có ít nhất 3 thuốc điều trị lao tấn công kết hợp.** Trong thời gian điều trị với corticoid cần theo dõi tác dụng phụ của thuốc như: loét dạ dày tá tràng hoặc xuất huyết dạ dày, loãng xương, rối loạn nội tiết... Để đạt được hiệu quả điều trị của corticoid thường phải dùng từ 1 – 2 tháng, giảm liều từ từ hàng tuần. Thường dùng Dexamethazone liều 2 – 3 mg/ngày hoặc prednisolone 20 – 60 mg/ngày.

4.4. Điều trị triệu chứng: Ngoài việc dùng thuốc đặc hiệu điều trị nguyên nhân, tùy theo thể bệnh lao chúng ta cần phải điều trị triệu chứng (nếu có) như ho ra máu, khó thở, sốt cao, co giật.v.v.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

4.4.1. Điều trị ho ra máu:(Xem bài "ho ra máu").

4.5. Vệ sinh, dinh dưỡng và phục hồi chức năng:

Tùy theo thể bệnh, chúng ta cần cho bệnh nhân tập luyện, phục hồi chức năng... như tập thở cơ hoành, thổi bong, tập vận động để chống dày dính trong lao màng phổi, hoặc vật lý trị liệu, vận động liệu pháp cho bệnh nhândi chứng lao màng não... để bệnh nhân làm quen với hoạt động gắng sức sớm trở về với cuộc sống lao động bình thường.

Mặc dù hiện nay đã có nhiều loại thuốc kháng lao đặc hiệu có thể chữa khỏi bệnh lao, nhưng vai trò chủ yếu cơ địa, chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng nâng cao đề kháng cũng là những yếu tố đáng quang tâm, vì nó góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng giúp cho quá trình khỏi bệnh đúng chất lượng và hiệu quả hơn.

5. Điều trị ngoại khoa:

Nhờ có thuốc kháng lao, biện pháp điều trị ngoại khoa đối với bệnh lao nhường chỗ cho điều trị nội khoa, măc dù trên phim X quang vẫn còn hình ảnh tổn thương di chứng nhưng không nhất thiết phải cắt bỏ. Chỉ định phẫu thuật chỉ còn ở một số trường hợp đặc biệt, hoặc chỉ để giải quyết di chứng:

- Dãn phế quản do lao khu trú gây biến chứng ho ra máu tái phát, số lượng nhiều có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng.
- Bội nhiễm nấm trong hang lao điều trị nội khoa không giải quyết được.
- Ổ cặn màng phổi, dày dính màng phổi nhiều gây hạn chế hô hấp.
- Lao cột sống có áp xe lạnh hoặc chèn ép thần kinh gây liệt.
- U lao khu trú > 2cm.

*** Điều kiện để một bệnh nhân lao phổi có thể được điều trị ngoại khoa kết hợp:**

- Tổn thương lao phổi khu trú ở một thùy hay một phân thùy.
- Bệnh nhân đã được điều trị nội khoa ít nhất 3 tháng.
- Chức năng phổi còn lại bình thường (chịu được cuộc phẫu thuật)
- Không có nhiễm trùng phụ kèm theo.
- Thể trạng bệnh nhân chịu được cuộc phẫu thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu phát tay.
2. Bệnh học lao và bệnh phổi, tập 1, NXB Y Học 1994.
3. Hướng dẫn thực hiện chương trình chống lao quốc gia, NXB Y Học 1999.
4. Tài liệu hướng dẫn bệnh lao, NXB Y Học 2001.
5. Bệnh học lao phổi, Phạm Long Trung, NXB Đà Nẵng 2000.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

6. Bệnh học lao, NXB Y Học Hà Nội 2002.
7. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao, Bộ Y tế, 2018

XỬ TRÍ CẤP CỨU HO RA MÁU DO LAO

A. HÀNH CHÍNH

1. Tên môn học: Bệnh lao
2. Tên tài liệu học tập: Xử trí cấp cứu ho ra máu do lao
3. Bài giảng: Lý thuyết
4. Số tiết: 1 tiết
5. Đối tượng sinh viên: Y5 hệ 6 năm
6. Địa điểm giảng: Giảng đường

B. MỤC TIÊU

1. Xác định được trường hợp ho ra máu.
2. Kể được một số nguyên nhân ho ra máu thường gặp.
3. Kể tên được một số thuốc thường dùng trong cấp cứu ho ra máu.
4. Xử trí được trường hợp ho ra máu cấp cứu lượng vừa.

C.NỘI DUNG

1. MỞ ĐẦU:

Ho ra máu (HRM) là một triệu chứng thường gặp trong bệnh học phổi phế quản nó chiếm 83,2% trong tổng số các nguyên nhân gây ho ra máu (Hoàng

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

Minh, 1990), trong số đó nguyên nhân do lao phổi chiếm >80%, vì vậy khi thấy một trường hợp HRM người ta thường cho rằng người đó mắc bệnh lao phổi.

HRM là một cấp cứu thường gặp trong cấp cứu hồi sức lao và bệnh phổi ở Việt nam. Tổng kết trên 1789 BN thấy HRM chiếm 54% số BN vào khoa cấp cứu Viện lao và bệnh phổi, nam chiếm 80%, phần lớn ở lứa tuổi 20-59 chiếm 83% (theo Hoàng văn Minh, 1997). Tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh) thấy HRM chiếm tỉ lệ khoảng 38% số BN vào khoa cấp cứu.

HRM là lý do khiến cho bệnh nhân (BN) phải đến khám tại các trung tâm chống lao và bệnh viện lao chiếm tỉ lệ 39%-52%.

Đối với các nước có tỉ lệ bệnh lao cao (như ở các nước đang phát triển) HRM là triệu chứng thường gặp và người ta thường nghĩ đến nguyên nhân là do lao phổi. Trong khi đó đối với các nước Tây Âu, bệnh lao không còn phổ biến thì khi có triệu chứng HRM người ta thường nghĩ đến nguyên nhân là do ung thư phổi.

2. KHÁI NIỆM VÀ CƠ CHẾ GÂY HO RA MÁU:

2.1. Khái niệm: HRM là máu chảy ra từ dưới thanh môn (đường hô hấp dưới) ho khạc (trào hoặc ộc) ra ngoài theo đường miệng hoặc mũi. Khái niệm này loại trừ khả năng chảy máu do tổn thương vùng mũi họng hay răng miệng, hoặc nôn ra máu do máu chảy từ đường tiêu hoá như do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản (do xơ gan gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa), loét dạ dày tá tràng, chảy máu đường mật... Máu nôn ra thường có đặc điểm không đỏ tươi (màu đen), không có bọt, có lẫn thức ăn, có mùi chua của dịch vị, đôi khi phân biệt rất khó vì chỉ nghe qua lời khai của BN.

2.2. Cơ chế gây HRM:

- Do giãn vỡ các mạch máu tân tạo (trong lao phổi), vỡ các phình mạch Rasmussen (do lao), rối loạn vận mạch do rối loạn thần kinh thực vật, stress... do dị ứng, hoặc do tổn thương ăn mòn thành của các mao mạch gây thủng, đứt hay vỡ các mao mạch, hoặc do tăng áp lực động mạch phế quản do tăng huyết áp.

- Điều kiện thuận lợi: Thay đổi thời tiết (gây rối loạn vận mạch), stress, bức xúc về mặt tâm lý tinh thần (tức giận, buồn, vui...), lao động nặng, gắng sức, thức khuya, ho nhiều hoặc có động tác hô hấp bất thường đột ngột (ho làm tăng áp lực đột ngột phổi phế quản làm rách, đứt tổn thương xơ co kéo tổ chức phổi).

3. NGUYÊN NHÂN GÂY HRM:

3.1. Nguyên nhân tại phổi:

- Lao phổi*:* là nguyên nhân thường gặp nhất chiếm > 80% tổng số các nguyên nhân gây HRM. Ho ra máu có thể gặp trong thời kỳ lao phổi mới đang tiến triển, lao xơ hang mạn tính, lao phổi tái phát, thậm chí lao phổi đã được điều trị khỏi (ta gọi đó là HRM di chứng do lao phổi cũ, hoặc di chứng giãn phế quản sau lao phổi).

- Giãn phế quản: Là nguyên nhân xếp thứ hai sau lao phổi, thường gặp ở thể khô, chiếm 9,6% trong tổng số nguyên nhân HRM (theo Hoàng Minh 1990).

- Ung thư phổi phế quản: tiên phát hoặc thứ phát là nguyên nhân xếp hàng thứ 3, chiếm 2,7% (Hoàng Minh 1990) trong tổng số nguyên nhân gây HRM, nhưng là triệu chứng thường gặp xếp hàng thứ 2 (chiếm 30,6%) sau triệu

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

chứng đau ngực trong ung thư phế quản (Nguyễn Đình Kim 1990). Trong ung thư phế quản số lượng máu ho ra thường không nhiều, máu thường có màu bầm đen (màu máu cá) cũng có khi đỏ tươi, lẫn đờm, số lượng ít.

- Các bệnh viêm nhiễm ở phổi: áp xe phổi, nấm phổi, sán lá phổi, viêm phổi, viêm phế quản cấp hoặc mạn tính, kén nước (kyst hydatique), phù phổi cấp tổn thương bởi hoá chất, dị vật phế quản, sặc xăng dầu...

- Các nguyên nhân khác ở phổi*:* bụi phổi, lạc nội mạc tử cung vào phổi, chấn thương ngực (do sức ép bom, sập hầm, gãy xương sườn), các thủ thuật nội soi phế quản, chọc dò sinh thiết phổi phế quản, kén phế quản...

3.2. Nguyên nhân ngoài phổi: Có khi không tìm thấy được nguyên nhân.

- Bệnh toàn thân: Bệnh ưa chảy máu (hemophilia), thể trạng chảy máu gồm cả do điều trị thuốc chống đông, sốt xuất huyết, rối loạn máu đông máu chảy, dị ứng, nhiễm khuẩn huyết, bệnh Scorbut, xuất huyết giảm tiểu cầu, suy tuỷ, bệnh bạch cầu cấp.v.v...

- Bệnh tim mạch và một số bệnh hiếm gặp khác:

+ Vỡ phình động mạch chủ ngực do xơ vữa động mạch, cao huyết áp (hiếm gặp thường gây chảy máu ồ ạt và chết nhanh chóng)

+ Thuyên tắc mạch phổi gây nhồi máu phổi, thông động tĩnh mạch

+ Hẹp van 2 lá, suy tim trái do cao huyết áp, phù phổi cấp (huyết động)

+ Cao huyết áp động mạch phổi nguyên phát.

+ Hội chứng Eisenmenger, Goodpasture, tinh bột phổi.

4. TRIỆU CHỨNG VÀ ĐẶC ĐIỂM HO RA MÁU:

4.1. Dấu hiệu báo trước: Trước khi ho ra máu bệnh nhân cảm thấy khó chịu, hồi hộp, nóng ran sau xương ức, ngứa họng khò khè, cảm giác có vị mặn hoặc mùi tanh trong họng sau đó ho khạc, nếu nhiều trào (ộc) ra ngoài theo đường miệng, mũi, hoặc nôn (ộc) ra sau cơn ho.

4.2. Đặc điểm: Lúc đầu máu ho ra thường có màu đỏ tươi (nếu mới chảy) hoặc nâu bầm đen do ứ đọng trong phổi, có bọt, có thể lẫn đờm. Vài ngày sau ho khạc máu ít dần, màu sắc chuyển thành màu nâu đen (như bã trầu) và sau đó hết hẳn (gọi là đuôi ho ra máu). Máu ho ra một hoặc nhiều lần, có thể kéo dài một hoặc vài ngày sau đó giảm dần và ngừng hẳn. Lưu ý có trường hợp sau khi ho bệnh nhân nuốt máu rồi nôn ra làm cho khó chẩn đoán. Đôi khi khó phân biệt ho hay nôn vì chỉ nghe lời khai của bệnh nhân hoặc người nhà.

4.3. Phân loại:

4.3.1. Phân loại mức độ HRM theo số lượng: tuỳ theo từng nước, theo thực tế ở Việt nam được chia 3 mức sau (Nguyễn Đình Kim 1999):

+ Ho ra máu ít (<50 ml/24 giờ): lượng máu ít, vệt máu lẫn đờm, có khi bệnh nhân không để ý và không đến khám bệnh, có thể chưa cần đặt vấn đề cấp cứu hồi sức.

+ Ho ra máu trung bình (50-200ml/24giờ): thường gặp, chiếm 2/3 số bệnh nhân vào cấp cứu vì ho ra máu, trường hợp này cần được cấp cứu hồi sức.

+ Ho ra máu nhiều (>200ml/24giờ): loại này chiếm 1/3 số bệnh nhân ho ra máu vào viện (Hoàng Minh-1990).

HRM được gọi là nặng khi:

- Ho ra máu thông thường (>200ml/24giờ)
- Ho ra máu tắc nghẽn (mặc dù lượng máu ho ra có thể ít)

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Ho ra máu từ 150ml kéo dài 2-3 ngày trở lên.

- Ho ra máu trung bình hoặc nhẹ nhưng kéo dài >15 ngày gây mất máu đáng kể, hồng cầu < 2 triệu/mm^3, hoặc Hematocrit < 20%

- Ho ra máu vừa ở bệnh nhân suy kiệt, có thai, suy hô hấp mãn tính, hoặc bệnh nặng kèm theo.

- Ho ra máu sét đánh: lượng máu nhiều, ồ ạt gây tử vong do tắc nghẽn và mất máu.

4.3.2. Phân loại theo hướng chẩn đoán nguyên nhân:

+ Ho ra máu triệu chứng (báo hiệu): HRM số lượng ít (không đặt vấn đề cấp cứu) nhưng cần thiết phải tìm nguyên nhân.

+ Ho ra máu bệnh (di chứng hay biến chứng): Ho ra máu nhiều, tái phát nhiều lần, thường là biến chứng hoặc di chứng của bệnh phổi đã biết, số lượng máu ra nhiều cần đặt vấn đề cấp cứu hồi sức.

4.4. Chẩn đoán xác định HRM, tìm vị trí và nguyên nhân:

Xác định HRM hay nôn ra máu: Dựa vào hỏi bệnh, tiền sử, tính chất và đặc điểm của máu ho ra, các khám nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng.

Đánh giá số lượng máu mất: Quan sát hoặc dựa vào lời khai, có thể ít hơn thực tế (do nuốt một phần), hoặc nhiều hơn (do đờm, nước bọt, giấy (khăn) lau lẫn nước.v.v...)

Đánh giá tổng trạng: - *Toàn thân:* da, niêm mạc, mạch, HA, nhịp thở, tình trạng suy nhược đặc biệt có suy hô hấp mãn tính.

- *Bệnh lý kèm theo:* nhiễm khuẩn, viêm phổi, tràn dịch màng phổi.

- *Cơ địa:* thai nghén, già yếu, suy kiệt, suy hô hấp.

Tìm vị trí chảy máu: dựa vào tổn thương Xquang phổi, vùng các mạch máu lớn tại rốn phổi, chảy máu trong hang lao (thấy mức dịch trong hang lao)...Ở nước ngoài người ta chủ trương soi phế quản bằng ống cứng (hoặc ống mềm) và chụp động mạch phế quản để xác định nơi chảy máu (khoảng 90% được nội soi cấp cứu, nhưng chụp động mạch phế quản cho kết quả hạn chế) nhằm mục đích tiên lượng mức độ nghiêm trọng của ho ra máu.

Trong khi xử trí cầm máu cần tích cực tìm nguyên nhân gây ho ra máu, đồng thời kết hợp điều trị nguyên nhân.

5. MỘT SỐ THUỐC THƯỜNG DÙNG TRONG CẤP CỨU HO RA MÁU

5.1. Thuốc giúp quá trình đông máu, ngăn cản chảy máu:

**** Vitamin K:*** (K1, K5) K1 nguồn gốc thực vật, K2 nguồn gốc động vật. Thuốc có tác dụng chống chảy máu, giúp quá trình đông máu, do tham gia quá trình tạo thành prothrombin của gan. Liều vitamin K 15mg, 40mg, hoặc 60mg/ngày, ống tiêm 1ml chứa 50mg hoặc 20mg.

**** Vitamin P, C:*** Có tác dụng tăng sức bền thành mạch, giảm tính thấm mao mạch, bảo vệ thành mạch khỏi bị tổn thương do Histamin. Dạng kết hợp vitamin P và C là Rutine (Rutabion, Rutinion) liều 10 - 20mg x 3lần/ngày.

**** Canxi*** (yếu tố IV) Là một chất xúc tác tham gia vào sự tạo thành prothrombin, chuyển prothrombin thành thrombin và biến Fibrinogen thành Fibrin. Dạng thuốc Canxiclorua, Canxigluconat.

**** Thrombine*** (Thrombase) Thrombofort, tiêm bắp 100UI/ngày là men phối hợp của 3 yếu tố cần cho quá trình đông máu đó là Thrombokinase,

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

Canxium & Prothrombine có tác dụng chuyển Fibrinogen -> Fibrin (sợi tơ huyết)

Thromboplastin hoặc Sistonal dùng ống 0,3g x 3 ống/ngày, tiêm bắp hoặc dưới da.

**** Adrenoxyl*** (gốc carbazochrom) tên khác Adrestat (Hà Lan), Adona (Nhật) là dẫn chất oxy hoá của Adrenalin, có tác dụng tăng cường sức chịu đựng của mao mạch, rút ngắn thời gian chảy máu. Viên nén 10mg dùng 1 - 3 viên/ ngày (trước bữa ăn 1 giờ), tiêm bắp hoặc dưới da, ống 1500µg (1,5mg) 1 - 4 ống/ngày.

**** Thuốc chống tiêu sợi huyết*** (EAC: ε aminocaproic acid): Tác dụng chống tiêu sợi huyết, còn có tác dụng chống sốc, chống dị ứng (do ngăn cản sự giải phóng Histamin, Serotomin). Dạng ống tiêm 5ml hay 10ml tương ứng 2g, tiêm tĩnh mạch 2-4 ống/ngày, hoặc tiêm truyền tĩnh mạch.

5.2. Thuốc có nguồn gốc thuốc phiện và an thần gây ngủ:

Đại diện là Morphin (Dolargan, Pethidine, Dolosal) tác dụng ức chế thần kinh trung ương, gây ngủ, ức chế trung tâm ho, ức chế phó giao cảm. Có tác dụng lên vỏ não làm giảm cảm ứng ngoại biên, làm giảm đau, điều chỉnh hoạt động của thần kinh thực vật, tăng sức chứa của các tĩnh mạch chi dưới nên làm giảm lượng máu qua phổi, gián tiếp điều hoà tuần hoàn phổi. Dạng thuốc ống tiêm 10mg/1ml, dùng 1-4 ống/ngày, thuốc gây nghiện nên không được dùng lâu quá 7 ngày. Chống chỉ định ở bệnh nhân suy hô hấp mãn tính.

5.3. Các thuốc đông miên nhân tạo: (gồm 3 loại)

+ Nhóm thuốc phiện: dùng Dolargan ống 100mg.

+ Nhóm Clopromazin (Aminazin ống 25mg). Tác dụng an thần trấn tỉnh, ức chế thần kinh trung ương, thần kinh thực vật, ức chế hệ giao cảm, ức chế tác dụng tăng huyết áp của Adrenalin làm hạ huyết áp, chống nôn.

+ Nhóm chống Histamin: Đại diện Pipolphen ống 50mg, thuốc tranh chấp với Histamin tại cơ quan cảm thụ (do chúng có công thức tương tự). Tác dụng lên hệ thần kinh trung ương làm giảm đau, tăng cường tác dụng của thuốc ngủ, thuốc mê.

5.4. Hocmon thuỳ sau tuyến yên: Oxytoxin tác dụng lên cơ tử cung. Vasopressin tác dụng co mạch, tăng huyết áp.

ADH (Antidiuretic Hocmon) là hocmon chống bài niệu, chưa tách được giữa Vasopressin và ADH. Ngày nay người ta dùng dưới dạng cao toàn phần của thuỳ sau tuyến yên. Thuốc có tên Glanduitrin, posthypophyse, hypantin, ống tiêm 1ml chứa 5 hay 10 UI, liều tiêm bắp 5-10 UI/ngày hoặc tiêm truyền tĩnh mạch.

5.5. Thuốc an thần gây ngủ:

An thần: Seduxen (Diazepam, valium....): Có tác dụng trấn tỉnh, ổn định hoạt động của hệ thần kinh thực vật.

Gây ngủ an thần: Phenobacbitan, viên 100mg, liều dùng 100-300mg/24giờ).

6. ĐIỀU TRỊ HRM:

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

6.1. Nguyên tắc chung:

- Chăm sóc chung: Trước hết cần để BN yên tĩnh, tránh những cử động, di chuyển, thăm khám không cần thiết (trường hợp HRM nhiều), có thể dùng thuốc an thần để trấn an BN giúp cho bệnh nhân yên tâm, bớt lo sợ, tin tưởng vào thầy thuốc.

- Điều trị triệu chứng: Cầm máu bằng một số thuốc đã trình bày trên.

- Hồi sức cấp cứu: Bảo đảm thông thoáng đường thở (thông khí phế nang) bằng cách hút đờm giãi, máu, nếu có doạ tắc nghẽn phế quản cần đặt nội khí quản hoặc mở khí quản, cho thở oxy qua sonde, hoặc thở máy khi cần thiết. Đồng thời bồi phụ khối lượng tuần hoàn bằng máu (nếu có mất máu nhiều), hoặc các dung dịch truyền thay thế như dung dịch cao phân tử, huyết thanh đẳng trương mặn hoặc ngọt. Lưu ý mục đích của truyền máu là để bù khối lượng máu mất và bảo đảm khối lượng tuần hoàn chứ không phải để bồi phụ các yếu tố đông máu.

- Điều trị nguyên nhân: Điều trị cầm máu chỉ có ý nghĩa khi đồng thời tìm và điều trị nguyên nhân kết hợp.

6.2. Xử trí một số trường hợp ho ra máu cụ thể:

6.2.1. Ho ra máu nhẹ: (<50ml/24giờ)

- Chăm sóc chung: BN cần được nghỉ ngơi yên tĩnh, hạn chế hoạt động, đi lại, tránh các yếu tố tâm lý tinh thần, stress (như buồn phiền, lo lắng, tức giận), động viên để BN yên tâm bớt lo sợ. Phần lớn máu có thể tự cầm. Dùng thức ăn lỏng, dễ tiêu (không dùng thức ăn uống nóng), uống nước mát.

- Có thể dùng thuốc an thần như Seduxen uống, thuốc cầm máu Adrenoxyl, vitamin K, vitamin P, C...

- Phần lớn các trường hợp này không cần đặc vấn đề cấp cứu hồi sức nhưng cần tích cực tìm nguyên nhân gây HRM.

6.2.2. Ho ra máu số lượng vừa: (50ml - 200ml/24giờ)

- Chăm sóc chung: Tương tự HRM nhẹ, để BN nằm ở tư thế Fowler hoặc nghiên về phía bên có tổn thương (nếu đã biết rõ).

- Thuốc dùng **post hypophyse** 5UI pha trong 10ml nước muối (hoặc đường) đẳng trương tiêm tĩnh mạch chậm, hoặc pha 10UI - 20UI trong 250ml huyết thanh đẳng trương truyền tĩnh mạch.

Hoặc dùng Morphin 10mg tiêm bắp (hoặc tĩnh mạch chậm) nếu không có tình trạng suy hô hấp mạn tính, có thể dùng lại sau 3 giờ nếu BN tiếp tục HRM.

6.2.3. Ho ra máu nhiều và nặng: (>200ml/24giờ)

- Chăm sóc chung: an thần tương tự như trên.

- Dùng hocmon thuỳ sau tuyến yên 10UI - 50UI pha trong 250ml dung dịch đẳng trương truyền tĩnh mạch, hoặc/và Morphin 10mg tiêm bắp hoặc dưới da.

- Bồi phụ khối lượng tuần hoàn bằng cách truyền máu nếu mất máu nhiều: truyền máu từ 250 - 750ml hoặc truyền dung dịch điện giải 1 - 3 lít/24giờ.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)

- Nếu BN HRM ồ ạt, sặc sụa nên dùng Morphin 5 - 10mg pha trong 10ml dung dịch đẳng trương tiêm tĩnh mạch chậm. Nếu dùng Morphin vẫn không đỡ HRM, có thể dùng đông miên nhân tạo (nếu không có chống chỉ định): Dolargan 100mg + Pipolphen 50mg + Aminazin 25 mg pha trong một lọ thuốc sạch dùng theo 2 cách:

+ *Cách 1:* Chia 2 hoặc 3 lần tiêm bắp/24giờ

+ *Cách 2:* Pha cả 3 ống thuốc trên trong 250ml dung dịch đẳng trương truyền tĩnh mạch 10 - 20 giọt/phút. Chú ý theo dõi sát mạch, huyết áp, nhịp thở. Nếu truyền nhanh có thể dẫn tới hôn mê, lưu ý thận trọng ở BN có suy hô hấp, người già, suy kiệt, phản xạ ho kém dễ dẫn đến tắc nghẽn phế quản.

- Làm thông thoáng đường thở bằng cách hút đờm giãi, hút máu, thở oxy.

- Dụng cụ mở khí quản phải chuẩn bị sẵn sàng khi có nguy cơ doạ tắc nghẽn phế quản, các tác giả nước ngoài khuyên nên chủ động đặt nội khí quản, hoặc đặt sonde Forgathy để bảo vệ phổi lành nếu có HRM nhiều.

- Mổ cấp cứu cắt bỏ phần phổi bị tổn thương, chỉ thực hiện được ở những cơ sở có đủ điều kiện

- Thủ thuật bít tắc động mạch phế quản (hiện nay ít dùng), được thực hiện khi HRM được điều trị ổn định (đã hoặc) có nguy cơ HRM tái phát nhiều lần với số lượng nhiều gây nguy hiểm đến tính mạng BN.

6.2.4. HRM doạ tắc nghẽn hoặc tắc nghẽn:

- Điều trị như HRM nặng

- Có thể đặt nội khí quản, hoặc mở khí quản mục đích bảo đảm thông thoáng đường thở, hút cục máu đông gây tắc, thở oxy qua sonde hoặc thở máy.

6.2.5. HRM sét đánh: Thường do vỡ đứt một mạch máu lớn trong hang lao, vỡ phình mạch lớn, hoặc đứt chỗ nối thông động mạch phổi - động mạch phế quản, BN chết ngay không kịp cấp cứu (mặc dù ở cơ sở có đủ điều kiện cấp cứu) do mất quá nhiều máu, truỵ mạch và tắc nghẽn diện rộng cây phế quản.

Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu phát tay

2. Bệnh học lao và bệnh phổi, tập 1, NXB Y học 1994.

3. Bài giảng bệnh lao và bệnh phổi, NXB Y học Hà Nội, 1999.

4. Bệnh học lao phổi, Phạm Long Trung, NXB Đà nẵng 2000

5. Bệnh học lao, Bộ môn lao trường Đại học Y Hà Nội, NXB Y học 2002.

Downloaded by Phi Ph?m (phipham27012005@gmail.com)